

Hematología



DESCGLOSES MIR

T01

Introducción:
fisiología
del eritrocito.
Anemia: concepto
y evaluación

- 1) Hepatitis alcohólica.
- 2) Hemocromatosis.
- 3) Anemia hemolítica autoinmune.
- 4) Acantocitosis.

Respuesta correcta: Anulada

P095 MIR 2018-2019

Hombre de 63 años en estudio por cuadro de astenia. En el hemograma se evidencia una hemoglobina de 9 g/dL, con un volumen corpuscular medio de 102 fL. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos le parece MENOS probable?

- 1) Intoxicación por plomo.
- 2) Alcoholismo.
- 3) Síndrome mielodisplásico.
- 4) Déficit de vitamina B₁₂.

Respuesta correcta: 1

P013 MIR 2025-2026

Pregunta asociada a imagen. Acude a urgencias un varón de 57 años, diagnosticado de una cirrosis etílica, sin descompensaciones previas, que mantiene un consumo de 2-3 cervezas al día. Ha comenzado con ictericia indolora en la última semana. En la exploración física únicamente destacan una franca ictericia cutánea y mucosa y ligeros edemas en ambas extremidades inferiores, sin ascitis. En la analítica encontramos hemoglobina: 11 g/dL, volumen corpuscular medio: 113 fL, Plaquetas $63 \times 10^9/L$, AST: 90 UI/L, ALT: 35 UI/L, gamma-glutamyltransferasa: 60 UI/L, bilirrubina total: 10 mg/dL, bilirrubina conjugada: 2.5 mg/dL, albúmina: 36 g/L, gammaglobulinas: 16 g/dL, ferritina: 500 mcg/L, saturación de transferrina: 59%, haptoglobina menor de 8 mg/dL. La morfología de sangre periférica es la que se muestra en la imagen. ¿Cuál es su diagnóstico?

T02

Aplasia de la
médula ósea.
Anemia
mieloitica

P085 MIR 2010-2011

Paciente con los siguientes parámetros en sangre periférica: Hb 10,5 g/dL, leucocitos $11.000/\mu L$ con 40% segmentados, 10% cayados, 5% metamielocitos, 4% mielocitos, 1% eosinófilos y 1% basófilos. Normoblastos 5%. Plaquetas $300.000/\mu L$. Morfología de serie roja en sangre: aniso-poiquilocitosis y dacriocitos. En la exploración se palpa esplenomegalia de 12 cm bajo reborde costal. ¿Qué diagnóstico, entre los siguientes, le sugieren estos datos?

- 1) Leucemia mieloide aguda tipo M6 (eritroleucemia).
- 2) Trombocitemia esencial.
- 3) Mielofibrosis primaria.
- 4) Leucemia linfoblástica aguda.
- 5) Leucemia mielomonocítica crónica.

Respuesta correcta: 3

P232 MIR 2012-2013

Un paciente de 29 años acude a su consulta con diagnóstico de aplasia medular severa. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

- 1) Transfusiones periódicas y antibióticos.
- 2) Andrógenos y transfusiones de plaquetas.

- 3) Trasplante de médula ósea alogénico si hermano HLA idéntico.
- 4) Trasplante autólogo de médula ósea para evitar rechazo.
- 5) Ciclosporina A y globulina antitumoral.

Respuesta correcta: 3

P105 MIR 2013-2014

Hombre de 71 años de edad que presenta analítica con pancitopenia severa sin presencia de células inmaduras y con estudio medular sugestivo de anemia aplásica grave. ¿Cuál sería el abordaje terapéutico fundamental?

- 1) Tratamiento con metilprednisolona en dosis de 1 g/kg/día durante 5 días.
- 2) Estudio de hermanos y si alguno es HLA compatible, trasplante alogénico de progenitores hemopoéticos.
- 3) Terapia inmunosupresora con ciclosporina e inmunoglobulina antitumoral.
- 4) Soporte hemoterápico.
- 5) Quimioterapia y, si respuesta, trasplante autólogo de progenitores hemopoéticos.

Respuesta correcta: 3

P081 MIR 2020-2021

En relación con la anemia de Fanconi indique la afirmación INCORRECTA:

- 1) La anemia aplásica suele estar ya presente en los primeros meses de vida.
- 2) Son típicas las malformaciones esqueléticas.
- 3) El trasplante de progenitores hematopoéticos es el tratamiento curativo, pero no hace desaparecer el riesgo de cáncer.
- 4) Los andrógenos suelen producir una respuesta favorable pero transitoria.

Respuesta correcta: 1

P033 MIR 2024-2025

Niña de 7 años con una sospecha de anemia de Fanconi. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas NO se ajusta a los rasgos típicos de esta enfermedad?

- 1) Anomalías pigmentarias.
- 2) Anomalías renales.

- 3) Anomalías esqueléticas.
- 4) Estatura alta.

Respuesta correcta: 4

T03 Anemias ferropénica y de enfermedad crónica

P093 MIR 2011-2012

Mujer de 35 años sana que consulta por astenia. En el hemograma presenta anemia microcítica e hipocroma (hemoglobina de 7 g/dL, volumen corpuscular medio de 68 fL, hemoglobina corpuscular media de 24 pg) con una amplitud de distribución eritrocitaria elevada (ADE 20%), reticulocitos disminuidos (0,3%, 30.000/ μ L absolutos), contenido de hemoglobina disminuido en los reticulocitos (17 pg) y discreta trombocitosis (500.000 plaquetas/ μ L). Con los datos del hemograma, ¿Cuál sería su sospecha diagnóstica aún sin tener la bioquímica de la paciente?

- 1) Rasgo talasémico.
- 2) Anemia central arregenerativa por déficit de ácido fólico.
- 3) Anemia periférica, regenerativa, hemolítica.
- 4) Anemia periférica, regenerativa, por hemorragia activa aguda.
- 5) Anemia central, arregenerativa por déficit de hierro.

Respuesta correcta: 5

P107 MIR 2013-2014

En una mujer de 29 años se hallan, en el curso de una analítica de rutina, los siguientes parámetros: Hb 11,5 g/dL, VCM 70 fL, HCM 28 pg, ferritina 10 ng/mL, leucocitos 5.200/ mm^3 , plaquetas 335.000/ mm^3 . La exploración física es normal. La exploración más indicada en esta situación es:

- 1) Exploración ginecológica.
- 2) Estudio de sangre oculta en heces.
- 3) Estudio radiológico de aparato digestivo.
- 4) Electroforesis de hemoglobina.
- 5) Test de Coombs.

Respuesta correcta: 1

P015 MIR 2015-2016

Pregunta vinculada a la imagen nº 15. Frotis de sangre perteneciente a una paciente multipara de 40 años con síndrome anémico, sin otros antecedentes de interés. Señalado en el frotis con una flecha, se observa un glóbulo rojo normal, de color y tamaño. ¿Qué estudio analítico, de los siguientes, proporcionaría el diagnóstico del tipo de anemia que padece esta paciente?

- 1) Nivel sérico de vitamina B₁₂.
- 2) Electroforesis de hemoglobinas.
- 3) Test de Coombs directo.
- 4) Nivel de ferritina en suero.

Respuesta correcta: 4

P091 MIR 2015-2016

La determinación en una mujer de 70 años de hematocrito 32%, Hb 9,6 g/dL, VCM 85 fL (70-99), hierro 25 mcg/dL (37-145) y ferritina 350 ng/mL (15-150) es más sugestivo de:

- 1) Pérdida de sangre reciente por aparato digestivo.
- 2) Malabsorción intestinal.
- 3) Polimialgia reumática.
- 4) Talasemia *minor*.

Respuesta correcta: 3

P050 MIR 2017-2018

La hepcidina tiene un papel central en la homeostasis del hierro. ¿Cuál de estas afirmaciones es CIERTA?

- 1) Su ausencia determina la sobrecarga de hierro.
- 2) El exceso de esta permite aumentar la absorción intestinal de hierro.
- 3) Se produce principalmente en el riñón.
- 4) Su síntesis no está influida por el hierro ingerido.

Respuesta correcta: 1

P200 MIR 2022-2023

Varón de 59 años, sin antecedentes personales, que consulta por astenia y disnea de esfuerzo de varios meses de evolución. En su historia clínica previa se



observa que no acude a consulta desde hace más de diez años. En la exploración física se detecta palidez conjuntival, siendo el resto normal. El electrocardiograma es normal y en el hemograma destaca: Hb 10,6 g/dL, Hcto 31 %, VCM 75 fL, ancho de distribución eritrocitaria 22 %. ¿Cuál de los siguientes sería el paso inicial APROPIADO?

- 1) Tacto rectal y programar colonoscopia.
- 2) Espirometría y programar broncoscopia.
- 3) Medir haptoglobina y realizar test de Coombs.
- 4) Medir vitamina B₁₂ y programar biopsia de médula ósea.

Respuesta correcta: 1

P155 MIR 2023-2024

En una anemia por deficiencia de hierro en una mujer joven por sangrado menstrual excesivo, sin otras complicaciones añadidas, ¿cuál de los siguientes parámetros analíticos estará aumentado?

- 1) Concentración de ferritina en suero.
- 2) Concentración de hemoglobina en reticulocitos.
- 3) Volumen corpuscular medio de los hematíes.
- 4) Concentración de transferrina en suero.

Respuesta correcta: 4

P178 MIR 2025-2026

Una mujer de 70 años consulta por astenia. Presenta una hemoglobina de 8,1 g/dL, VCM de 72 fL (rango: 84-100 fL) y CHCM de 25 g/dL (rango: 31,5-34,5 g/dL). En el hemograma, tiene una cifra de plaquetas de 530.000/mcL. En la bioquímica, la LDH, la bilirrubina y la función renal son normales. Revisando sus analíticas previas, años atrás normales, observamos que las alteraciones han ido desarrollándose de forma progresiva en el último año. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y qué prueba/s solicitaría para continuar el estudio de esta paciente?

- 1) Trombocitemia esencial. Estudio de médula ósea.
- 2) Betatalasemia intermedia. Electroforesis de hemoglobinas y estudio genético.

- 3) Esferocitosis hereditaria. Prueba de unión con esosina-5'-maleimida (EMA).
- 4) Anemia ferropénica. Ferritina sérica y estudios digestivos.

Respuesta correcta: 4

T04 Anemias megaloblásticas

P078 MIR 2010-2011

Ante un paciente con una cirugía abdominal urgente, usted tiene su informe de quirófano en el cual nos señalan que se ha localizado una resección de todo el duodeno y del tercio proximal del yeyuno, manteniendo íntegros el estómago y todo el íleon, así como los dos tercios distales del yeyuno. En el seguimiento nutricional del paciente, ¿Qué vitamina o mineral presentará con menos probabilidad una disminución de su absorción y, por tanto, no produciría manifestaciones clínicas secundarias a su déficit?

- 1) Vitamina B₁₂.
- 2) Calcio.
- 3) Hierro.
- 4) Magnesio.
- 5) Ácido fólico.

Respuesta correcta: 1

P086 MIR 2010-2011

¿Qué etiología habría que suponer ante una anemia de 5 g/dL de Hb, VCM de 125 fL, reticulocitos de 2 por mil, LDH 5 veces superior al límite normal e hiperbilirrubinemia no conjugada?

- 1) Anemia de los trastornos crónicos.
- 2) Anemia hemolítica.
- 3) Talasemia.
- 4) Enfermedad de Wilson.
- 5) Anemia por carencia de vitamina B₁₂.

Respuesta correcta: 5

P092 MIR 2012-2013

Los siguientes hallazgos están presentes tanto en la deficiencia de ácido fólico

como en la deficiencia de vitamina B₁₂, EXCEPTO uno:

- 1) Hematíes macrocíticos.
- 2) Neuropatía periférica.
- 3) Maduración megaloblástica en la médula ósea.
- 4) Niveles elevados de lactato deshidrogenasa (LDH) y bilirrubina indirecta.
- 5) Hipersegmentación de neutrófilos.

Respuesta correcta: 2

P212 MIR 2014-2015

Señalar la respuesta VERDADERA en relación al metabolismo de la vitamina B₁₂:

- 1) La vitamina B₁₂ se absorbe en el duodeno.
- 2) El factor intrínseco se combina con la vitamina B₁₂ en el estómago protegiéndola de la digestión y de su paso por el intestino delgado.
- 3) El complejo vitamina B₁₂-factor intrínseco se une a receptores de la superficie epitelial yeyunal.
- 4) Aún en ausencia del factor intrínseco, la cantidad de vitamina B₁₂ de la dieta es suficiente para el proceso de maduración de los eritrocitos jóvenes.
- 5) El factor intrínseco proviene de la dieta.

Respuesta correcta: Anulada

P016 MIR 2016-2017

Pregunta vinculada a la imagen nº 16. Mujer de 54 años de raza negra que presenta astenia, somnolencia, parestesias, trastorno de la marcha, y pérdida de fuerza y de sensibilidad en ambas extremidades inferiores. Los análisis mostraron Hb 10,4 g/dL, VCM 107 fL, plaquetas 110.000/mm³, leucocitos 5.000/mm³, neutrófilos 1.900/mm³, linfocitos 2.500/mm³, monocitos 300/mm³, eosinófilos 300/mm³, reticulocitos 1,0% (normal: 0,5-2), reticulocitos totales 5.400/mm³, haptoglobina 0 g/L (normal 0,3-2 g/L), LDH 1.114 U/L, AST (GOT) 50 U/L, ALT (GPT) 30 U/L, GGT 16 U/L, fosfatasa alcalina 90 U/L, bilirrubina total 1,03 mg/dL. Test de Coombs negativo. El frotis de sangre periférica se muestra en la imagen. Valorado el cuadro clínico y analítico, ¿cuál es el tratamiento que se debe administrar a esta paciente?

- 1) Recambio plasmático.
- 2) Corticoides orales.
- 3) Vitamina B₁₂ parenteral.
- 4) Ácido fólico y esplenectomía.

Respuesta correcta: 3

P106 MIR 2017-2018

Mujer de 40 años que consulta por anemia. En la analítica destacan Hb 10,5 g/dL, ferropenia, macrocitosis e hipergastrinemia. Tiene antecedentes artropatía lúpica y enfermedad de Graves Basedow. Está en tratamiento con prednisona 15 mg/día, colchicina 0,5 mg cada 12 horas y metimazol 10 mg/día. ¿Cuál considera la causa MÁS probable de la anemia?

- 1) Pérdidas hemáticas en relación con el tratamiento esteroideo.
- 2) Hipoplasia medular 2º a colchicina.
- 3) Hemólisis secundaria a la toma de metimazol.
- 4) Gastritis tipo A.

Respuesta correcta: 4

P149 MIR 2022-2023

Varón de 65 años que consulta por astenia progresiva y sensación de hormigueo en manos y pies. En la exploración física presenta tez amarillenta y disminución de la sensibilidad vibratoria y posicional en zonas distales. En el hemograma se observa VCM 120 fL con anisocitosis. Lo MÁS probable es que padezca:

- 1) Mielopatía cervicoartrósica.
- 2) Mielitis necrosante subaguda.
- 3) Mielosis funicular.
- 4) Mielopatía crónica de la esclerosis múltiple.

Respuesta correcta: 3

T05 Anemias hemolíticas

P103 MIR 2009-2010

¿Cuál de los siguientes datos NO es propio del síndrome hemolítico?

- 1) Adenopatías.
- 2) Esplenomegalia.
- 3) Hiperbilirrubinemia.

- 4) Incremento LDH sérica.
- 5) Reticulocitosis.

Respuesta correcta: 1

P104 MIR 2009-2010

En un paciente con hemoglobina de 11 g, número de hematíes ligeramente elevado, pero hipocromos y microcíticos y con niveles elevados de hemoglobina A2, ¿Cuál sería su diagnóstico?

- 1) Anemia ferropénica.
- 2) Alfa talasemia *minor*.
- 3) Betatalasemia *minor*.
- 4) Rasgo falciforme.
- 5) Anemia de Cooley.

Respuesta correcta: 3

P092 MIR 2011-2012

¿Cuál de los siguientes datos NO es propio del síndrome hemolítico?

- 1) Adenopatías.
- 2) Esplenomegalia.
- 3) Hiperbilirrubinemia.
- 4) Incremento LDH sérica.
- 5) Reticulocitosis.

Respuesta correcta: 1

P094 MIR 2011-2012

Mujer de 32 años con parálisis cerebral del parto que acude a Urgencias por cuadro de orinas oscuras de unos días de evolución en relación con episodio de fiebre alta y tos seca. Al ingreso se objetiva en el hemograma 16.900 leucocitos/mm³ (85% S; 11% L; 4% M), hemoglobina de 6,3 g/dL; VCM 109 fL; 360.000 plaquetas/mm³. En la bioquímica LDH 2408 UI/L; Bilirrubina 6,8 mg/dL (Bilirrubina no conjugada 6,1 mg/dL) GOT y GPT normales. En el estudio morfológico de sangre se observa anisocitosis macrocítica con frecuentes formas esferocitadas y policromatofilia sin blastos. El estudio de anticuerpos irregulares es positivo en forma de panaglutinina, dificultando la prueba cruzada. ¿Cuál sería su sospecha diagnóstica en el tratamiento más adecuado?

- 1) Aplasia medular e inmunoterapia con timo-globulina y ciclosporina.

- 2) Esferocitosis hereditaria y esplenectomía.
- 3) Anemia hemolítica autoinmune asociada a infección respiratoria y corticoides.
- 4) Anemia perniciosa e inyecciones periódicas de vitamina B₁₂.
- 5) Leucemia aguda y quimioterapia.

Respuesta correcta: 3

P229 MIR 2011-2012

Hombre de 54 años, con antecedentes personales de DM, HTA e insuficiencia renal crónica leve, que presenta somnolencia y hemiparesia derecha. En la analítica: creatinina de 2,3 mg/dL, Hb 10,3 g/dL y plaquetas 20.000/mm³, con coagulación normal. En TC craneal: lesiones isquémicas con necrosis microhemorrágicas. Posteriormente comienza con deterioro progresivo del nivel de conciencia y aumento de Cr, LDH y bilirrubina no conjugada. Se realiza Coombs directo que es negativo. Esquistocitos en frotis. Ante la sospecha diagnóstica la conducta a seguir es:

- 1) Nuevo TC craneal ante la sospecha de transformación hemorrágica de ictus isquémico.
- 2) Iniciar plasmaféresis urgente.
- 3) Inicio de tratamiento con glucocorticoides a dosis de 1 mg/kg/día.
- 4) Buscar causa desencadenante de cuadro de CID.
- 5) Sospecha de mieloma múltiple: aspirado de médula ósea.

Respuesta correcta: 2

P093 MIR 2012-2013

A una mujer de 30 años, asintomática, en un examen rutinario se le detecta anemia. En la exploración física se aprecia ictericia conjuntival y esplenomegalia. La paciente refiere historia familiar de litiasis biliar en edades tempranas. Todo ello sugiere el diagnóstico más probable de:

- 1) Déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa.
- 2) Talasemia *minor*.
- 3) Deficiencia de vitamina B₁₂ y/o ácido fólico.
- 4) Déficit familiar de piruvatoquinasa.
- 5) Esferocitosis hereditaria.

Respuesta correcta: 5



P077 MIR 2014-2015

En relación con la Esferocitosis Hereditaria es cierto que:

- 1) Es una anemia hemolítica congénita de herencia ligada al cromosoma X que es causa de anemia severa.
- 2) Se caracteriza por una disminución de la fragilidad osmótica.
- 3) Se manifiesta como episodios de anemia aguda medicamentosa.
- 4) El tratamiento de elección cuando es sintomática es la esplenectomía.
- 5) Raramente se asocia a colelitiasis.

Respuesta correcta: 4

P078 MIR 2014-2015

Paciente de 45 años que acude a urgencias por malestar general, cefalea y cansancio progresivo en las últimas semanas. A la exploración física se detecta un ligero tinte icterico de piel y mucosas y se palpa esplenomegalia de 2 cm bajo el reborde costal. La analítica presenta hemoglobina 8,6 g/dL, VCM 100 fL. La cifra de reticulocitos está elevada y en el frotis de sangre se observa anisopoiquilocitosis. En la bioquímica destaca LDH 1300 UI/L, bilirrubina 2,2 mg/dL y haptoglobina indetectable. ¿Qué prueba es la más apropiada para orientar el diagnóstico de la paciente?

- 1) Test de sangre oculta en heces.
- 2) Test de Coombs.
- 3) Determinación de hierro, cobalamina y ácido fólico.
- 4) Ecografía abdominal.
- 5) Aspirado de médula ósea.

Respuesta correcta: 2

P017 MIR 2016-2017

Pregunta vinculada a la imagen nº 17. Nos es remitido desde Atención Primaria un paciente joven de 22 años de edad para estudio. Es originario de Jamaica y lleva cinco meses viviendo en España. El motivo de consulta al médico de familia fue una sensación de cansancio. Como antecedentes explica unos dolores de varios años de evolución en diversas articulaciones, de intensidad moderada, sin signos inflamatorios, que no habían sido estudiados en su país. La exploración clí-

nica muestra palidez de mucosas y una lesión ulcerada dolorosa en la pierna de tres años de evolución por la que no había consultado. No recordaba ningún traumatismo local. La analítica muestra una Hb de 7,6 g/dL, reticulocitos 417.000/μL, Hto 22,8%, leucocitos 13.540/μL, con 51% de neutrófilos y 36% de linfocitos, plaquetas 286.000/μL, bilirrubina 2,12 mg/dL, (directa 0,4 mg/dL) y lactato deshidrogenasa 318 U/L (VN < 190 U/L). Un estudio básico de la coagulación se encuentra dentro de los rangos normales. La radiografía de tórax es normal, así como un Eco-Doppler de extremidades inferiores. ¿Qué tipo de anemia sospecharía Ud. antes de iniciar los correspondientes estudios confirmatorios?

- 1) Anemia por células falciformes.
- 2) Anemia hemolítica autoinmune.
- 3) Anemia por enfermedad crónica.
- 4) Anemia por déficit de hierro.

Respuesta correcta: 1

P229 MIR 2016-2017

Señale cuál de los siguientes anticuerpos monoclonales ha demostrado su eficacia en el tratamiento de la hemoglobinuria paroxística nocturna:

- 1) Rituximab.
- 2) Alemtuzumab.
- 3) Eculizumab.
- 4) Ocrelizumab.

Respuesta correcta: 3

P010 MIR 2017-2018

Pregunta vinculada a la imagen nº 10. Una mujer de 40 años acude al Servicio de Urgencias por síndrome anémico. En la exploración física se observa palidez mucocutánea con tinte icterico en conjuntivas. En los análisis de sangre periférica destacan los siguientes datos: leucocitos 7.380/mcL, hemoglobina 7,6 g/dL, VCM 97 fL, plaquetas 78.000/mcL, LDH 1.092 U/L, bilirrubina total 3,4 mg/dL y bilirrubina indirecta 2,9 mg/dL. Ante los hallazgos del frotis de sangre periférica, indique el diagnóstico de sospecha CORRECTA:

- 1) Anemia hemolítica autoinmune.
- 2) Mielofibrosis.

- 3) Anemia hemolítica microangiopática.
- 4) Anemia drepanocítica.

Respuesta correcta: 3

P096 MIR 2018-2019

Una mujer de 40 años se va a someter a cirugía por colelitiasis. Presenta discreta esplenomegalia en la exploración física y en la analítica: Hb 9 g/dL, VCM 80 fL, CHCM 38 g/dL, LDH 500 U/L y reticulocitos del 10%. ¿Cuál es el diagnóstico MÁS probable?

- 1) Esferocitosis hereditaria.
- 2) Drepanocitosis.
- 3) Anemia hemolítica autoinmune.
- 4) Anemia sideroblástica.

Respuesta correcta: 1

P172 MIR 2020-2021

Mujer de 19 años, con antecedentes familiares de anemia, que presenta datos de anemia hemolítica crónica, Coombs directo negativo. ¿Cuál sería el diagnóstico MÁS probable?

- 1) Esferocitosis hereditaria.
- 2) Déficit de piruvatoquinasa eritrocitaria.
- 3) Betatalasemia *major*.
- 4) Hemoglobinuria paroxística nocturna.

Respuesta correcta: 1

P173 MIR 2020-2021

Mujer de 70 años que acude a Urgencias por astenia. En el examen físico destacan palidez cutaneomucosa con subictericia conjuntival y un soplo pansistólico audible en todos los focos. Analíticamente destaca hemoglobina 8 g/dL, VCM 100 fL, LDH 900 U/L, haptoglobina indetectable y bilirrubina total 3,5 mg/dL. Se le solicitó la determinación de una prueba inmunohematológica. Señale la afirmación CORRECTA:

- 1) El diagnóstico más probable es el de saturnismo; debemos solicitar plomo en orina de 24 horas.
- 2) Se trata de una anemia hemolítica; para determinar su naturaleza debemos solicitar una electroforesis de hemoglobinas.

- 3) Se trata de una anemia hemolítica; debemos solicitar un test de Coombs directo, que determina la presencia de IgG y/o la fracción C3 del complemento sobre la membrana del hematíe.
- 4) Se trata de una anemia hemolítica; debemos solicitar un test de Coombs directo, que determina la presencia de IgG libre en plasma.

Respuesta correcta: 3

P010 MIR 2022-2023

Pregunta vinculada a la imagen nº 10. Varón de 38 años de origen centroafricano que presenta el siguiente frotis (imagen vinculada). Con respecto a la enfermedad que sospecha, señale la afirmación CORRECTA:

- 1) La esplenomegalia es un hallazgo frecuente en los cuadros de larga evolución.
- 2) Puede producir episodios dolorosos por crisis oclusivas vasculares.
- 3) Es debida a un defecto congénito en las proteínas de la membrana eritrocitaria.
- 4) En el examen del frotis sanguíneo se observa trombopenia y numerosos esquistocitos.

Respuesta correcta: 2

P021 MIR 2024-2025

Pregunta vinculada a la imagen nº 21. Pregunta asociada a la imagen 21. Mujer de 57 años con enfermedad renal crónica que presenta astenia, hipotensión y cianosis en manos tras una sesión de diálisis. En la analítica se detecta anemia normocítica (Hb 7 g/dL, VCM 96 fL) con discreta reticulocitosis, leucocitos y plaquetas normales; aumento de LDH y hemoglobina libre en plasma elevada. El estudio inmunohematológico muestra un anticuerpo con especificidad anti-P. Se realiza frotis sanguíneo (ver imagen) mediante punción digital. El diagnóstico más probable es:

- 1) Síndrome hemofagocítico.
- 2) Hemoglobinuria paroxística a frigore.
- 3) Hemoglobinuria paroxística nocturna.
- 4) Crioglobulinemia.

Respuesta correcta: 2

P139 MIR 2025-2026

Mujer de 55 años diagnosticada de lupus eritematoso sistémico. Consulta por astenia en los últimos tres meses. En la analítica destacan eritrocitos: $3 \times 10^{12}/L$, Hemoglobina: 9,1 g/dL, volumen corpuscular medio: 81 fL, reticulocitos: $250 \times 10^9/L$, leucocitos: $7.2 \times 10^9/L$, plaquetas: $230 \times 10^9/L$. Sideremia: 25 mcg/dL, saturación de transferrina: 19%. Ferritina: 400 ng/mL ¿Qué tipo de anemia tiene esta paciente?

- 1) Anemia inflamatoria crónica.
- 2) Anemia ferropénica.
- 3) Anemia hemolítica.
- 4) Talasemia menor.

Respuesta correcta: Anulada

P143 MIR 2025-2026

Un paciente de 39 años que presenta emisión recidivante de orina rojiza, episodios repetidos de dolor abdominal de etiología no diagnosticada, acude a Urgencias con un nuevo episodio de dolor abdominal intenso. En los estudios realizados en Urgencias se objetiva una trombosis venosa mesentérica. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha que considera MÁS probable?

- 1) Hemoglobinuria paroxística nocturna.
- 2) Síndrome antifosfolípido.
- 3) Coproporfiria eritropoyética.
- 4) Fiebre mediterránea familiar.

Respuesta correcta: 1

T06 Síndromes mielodisplásicos

P109 MIR 2009-2010

Un paciente de 55 años con antecedentes de linfoma de Hodgkin tratado 7 años antes con quimio-radioterapia seguida de un autotrasplante de médula ósea presenta desde hace 10-12 meses cansancio y los siguientes datos de laboratorio: Hb: 10 g/dL; VCM: 110 fL; Leucocitos: $5.900/mm^3$ (neutrófilos: 35%; linfocitos: 50%; monocitos: 15%; plaquetas $85.000/mm^3$). ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?

- 1) Hipotiroidismo radiógeno.
- 2) Recaída medular del linfoma.
- 3) Anemia megaloblástica.
- 4) Síndrome mielodisplásico.
- 5) Trombopenia de origen inmune.

Respuesta correcta: 4

P095 MIR 2011-2012

¿Cuál de las siguientes drogas es útil en el síndrome mielodisplásico?

- 1) Azacitidina.
- 2) Imatinib.
- 3) Bortezomib.
- 4) Rituximab.
- 5) Zoledronato.

Respuesta correcta: 1

P094 MIR 2015-2016

Hombre de 51 años que es ingresado desde Urgencias por anemia macrocítica (Hb 6,3 g/dL, VCM 120 fL). En los estudios realizados se descarta origen carencial. Los reticulocitos son de 24.000/mcL. El estudio de médula ósea es compatible con un síndrome mielodisplásico (SMD). La citogenética muestra una delección en 5q. ¿Cuál es la afirmación correcta en relación con este paciente?

- 1) Esta delección (5q-) es una alteración de buen pronóstico y tiene un tratamiento específico (la lenalidomida).
- 2) Lo recomendable en este paciente sería realizar tipajes HLA para organizar un trasplante alogénico.
- 3) Se trata de un paciente con Índice Internacional de Pronóstico (IPSS) alto.
- 4) El tratamiento en este caso serían las transfusiones, únicamente.

Respuesta correcta: 1

P097 MIR 2016-2017

¿Cuál de los siguientes parámetros NO forma parte del International Prognostic Scoring System – IPSS – para los síndromes mielodisplásicos?

- 1) El porcentaje de blastos en la médula ósea.
- 2) El cariotipo.
- 3) La dependencia transfusional de concentrados de hematíes.



4) El recuento de plaquetas en la sangre periférica.

Respuesta correcta: 3

P154 MIR 2023-2024

Paciente de 62 años en estudio por una pancitopenia. Se realiza una punción de la medula ósea objetivando un 15% de blastos mieloides con estudio citogenético normal. Según la clasificación de enfermedades de la OMS el proceso debería ser catalogado como:

- 1) Leucemia mieloide aguda.
- 2) Síndrome mielodisplásico con exceso de blastos.
- 3) Anemia megaloblástica.
- 4) Aplasia medular.

Respuesta correcta: 2

T08 Neoplasias mieloproliferativas crónicas

P081 MIR 2010-2011

Un paciente de 69 años acude al Servicio de Urgencias por debilidad, fatiga y epistaxis de repetición. El hemograma muestra anemia (hemoglobina 8,5 g/dL), leucopenia (leucocitos 1.200/mm³), y trombopenia (plaquetas 35.000/mm³). ¿Cuál es el diagnóstico MENOS probable?

- 1) Aplasia medular.
- 2) Síndrome mielodisplásico.
- 3) Leucemia mieloblástica aguda.
- 4) Leucemia mieloide crónica.
- 5) Mielofibrosis.

Respuesta correcta: 4

P096 MIR 2011-2012

La mutación del gen JAK-2 constituye uno de los criterios mayores de diagnóstico en una de estas patologías:

- 1) Policitemia vera.
- 2) Leucemia mieloide aguda tipo M4 de la FAB.
- 3) Síndrome mielodisplásico tipo anemia refractaria.

- 4) Leucemia mieloide crónica.
- 5) Leucemia mielomonocítica crónica.

Respuesta correcta: 1

P096 MIR 2012-2013

Un hombre de 58 años, no fumador y sin antecedentes personales relevantes, es ingresado en la planta de neurología por un accidente cerebrovascular agudo isquémico. Su hemograma muestra 18.5 g/dL de hemoglobina con un hematocrito de 60%. Todos los siguientes datos concuerdan con el diagnóstico de Policitemia vera, EXCEPTO uno. Señálelo:

- 1) Niveles de eritropoyetina séricos elevados.
- 2) Presencia de la mutación V617F del gen JAK-2.
- 3) Esplenomegalia moderada.
- 4) Presencia de prurito "acuágeno" y eritromelalgia.
- 5) Presencia de leucocitosis neutrofílica y trombocitosis.

Respuesta correcta: 1

P031 MIR 2013-2014

Pregunta vinculada a la imagen nº 16. Paciente de 48 años, fumador. Consulta por crisis de enrojecimiento simétrico y bilateral en ambos pies, acompañado de dolor urente (imagen). La exploración general, el examen neurológico y los pulsos periféricos son normales. En la analítica destaca: Hb 16,8 g/dL, leucocitos 12.400/mm³, plaquetas 720.000/mm³. Bioquímica: glucosa 87 mg/dL, creatinina 0,7 mg/dL, proteínas 7,5 g/dL, calcio 9,4 mg/dL, GOT 40 U/L, GPT 35 U/L, GGT 64 U/L, FA 124 U/L, LDH 187 U/L, VSG 24 mm/h. Hemostasia e inmunoglobulinas normales. Serología frente a virus de hepatitis B y C negativa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- 1) Livedo reticularis.
- 2) Eritromelalgia.
- 3) Enfermedad de Buerger.
- 4) Mastocitosis sistémica.
- 5) Crioglobulinemia mixta.

Respuesta correcta: 2

P032 MIR 2013-2014

Pregunta vinculada a la imagen nº 16. ¿Cuál de las siguientes apoyará el diagnóstico de la enfermedad de base?

- 1) Biopsia cutánea.
- 2) Microangiografía.
- 3) Determinación de crioglobulinas.
- 4) Triptasa sérica.
- 5) Estudio de mutación JAK 2.

Respuesta correcta: 5

P084 MIR 2014-2015

El prurito es una manifestación típica de todas las siguientes enfermedades, salvo:

- 1) Linfoma de Hodgkin.
- 2) Policitemia vera.
- 3) Micosis fungoide.
- 4) Mastocitosis sistémica.
- 5) Leucemia aguda mieloblástica.

Respuesta correcta: 5

P096 MIR 2016-2017

¿En cuál de los siguientes tipos de leucemia el uso de Imatinib es el elemento terapéutico clave para el control de la enfermedad a largo plazo?

- 1) Leucemia mieloblástica aguda.
- 2) Leucemia mieloide crónica.
- 3) Leucemia prolinfocítica crónica.
- 4) Leucemia linfocítica crónica.

Respuesta correcta: 2

P101 MIR 2018-2019

Hombre de 60 años con el siguiente hemograma: leucocitos 10.000/μL con desviación izquierda, Hb 11 g/dL y plaquetas 1.870.000/μL con importante anisotrombocitosis. Moderada esplenomegalia en el examen físico. En el estudio molecular se detecta reordenamiento del gen bcr/abl y no se detecta mutación en el gen JAK2. ¿Cuál es el diagnóstico CORRECTO?

- 1) Trombocitemia esencial.
- 2) Leucemia mieloide crónica.

- 3) Mielofibrosis en fase prefibrótica.
- 4) Leucemia aguda megacarioblástica.

Respuesta correcta: 2

P016 MIR 2023-2024

Pregunta vinculada a la imagen nº 16. En la mielofibrosis primaria se observan en el frotis sanguíneo (ver imagen) unos hematíes con una forma característica denominados:

- 1) Dacriocitos.
- 2) Piropluquilocitos.
- 3) Esquistocitos.
- 4) Acantocitos.

Respuesta correcta: 1

P024 MIR 2025-2026

Un varón de 69 años consulta por astenia y adelgazamiento. En la exploración física, presenta esplenomegalia de 5 cm por debajo del reborde costal. En el hemograma, hemoglobina de 10 g/dL y plaquetas de 630.000/mcL, y presencia de leucoeritroblastosis en el frotis de sangre periférica. Revisando su historial analítico comprueba que ya se observaba una cifra similar de plaquetas cinco años atrás, pero la hemoglobina y el frotis eran normales. Se realiza un aspirado de médula ósea que resulta seco. En la biopsia ósea de solicita una tinción con plata para medirreticulina (imagen vinculada). El estudio genético revela la presencia de la variante patogénica en *JAK2* que genera el cambio V617F y una variante patogénica en *ASXL1*. ¿Cuál es el diagnóstico MÁS probable de este paciente?

- 1) Mielofibrosis posttrombocitemia esencial.
- 2) Aplasia medular.
- 3) Leucemia mielomonocítica crónica.
- 4) Leucemia mieloide crónica.

Respuesta correcta: 1

T09 Leucemia linfática crónica

P082 MIR 2010-2011

La hipogammaglobulinemia es un hallazgo frecuente en los enfermos con:

- 1) Linfoma de Hodgkin.
- 2) Leucemia linfática crónica.
- 3) Linfoma de células grandes.
- 4) Tricoleucemia.
- 5) Linfoma folicular.

Respuesta correcta: 2

P083 MIR 2010-2011

Un paciente de 74 años de edad es diagnosticado de leucemia linfática crónica B estadio IIB de RAI-BINET. Tras recibir 6 ciclos de fludarabina, presenta astenia importante y palidez de la piel y mucosas. En la analítica destaca: leucocitos 5.600/ μ L con fórmula normal, hemoglobina 3 g/dL y plaquetas 250.000/ μ L. Reticulocitos 0%. Niveles normales de LDH y test de Coombs directo negativo. El diagnóstico más probable es:

- 1) Progresión de la enfermedad a leucemia prolinfocítica B.
- 2) Anemia hemolítica autoinmune.
- 3) Síndrome de Richter.
- 4) Aplasia pura de células rojas.
- 5) Síndrome de lisis tumoral.

Respuesta correcta: 4

P019 MIR 2013-2014

Pregunta vinculada a la imagen nº 10. Hombre de 74 años, asintomático, que en una analítica de rutina tiene leucocitos 37.000/mL, hemoglobina 15,7 g/dL, plaquetas 190.000/mL. En la exploración no se aprecian adenopatías ni organomegalias. Se hace una extensión de sangre periférica (imagen). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- 1) Viriasis.
- 2) Leucemia mieloide crónica.
- 3) Gammapatía monoclonal de significado incierto.
- 4) Leucemia linfática crónica.
- 5) Síndrome mielodisplásico.

Respuesta correcta: 4

P020 MIR 2013-2014

Pregunta vinculada a la imagen nº 10. Ante este cuadro clínico, ¿Cuál sería el tratamiento más indicado?

- 1) No tratar, esperar y ver.
- 2) Interferón.
- 3) Clorambucilo y prednisona.
- 4) Inhibidores de bcr/abl (imatinib).
- 5) Ciclofosfamida, vincristina y prednisona.

Respuesta correcta: 1

P095 MIR 2015-2016

La tricoleucemia (leucemia de células peludas) presenta como rasgos característicos clínico-biológicos:

- 1) Linfocitosis en sangre periférica superior a 50.000 linfocitos/mcL.
- 2) Marcadores de línea linfocítica T.
- 3) Eritrodermia generalizada exfoliativa, placas y tumores cutáneos.
- 4) Pancitopenia y esplenomegalia.

Respuesta correcta: 4

P098 MIR 2016-2017

¿Cuál de estas complicaciones NO es propia de la leucemia linfática crónica?

- 1) Trombosis venosas
- 2) Hipogammaglobulinemia.
- 3) Segundas neoplasias.
- 4) Anemia hemolítica autoinmune.

Respuesta correcta: 1

P100 MIR 2016-2017

Hombre de mediana edad, sano hasta que fue diagnosticado de linfoma de no-Hodgkin, siendo tratado con quimioterapia (CHOP) y anticuerpos anti-CD20 (Rituximab). Alcanzó remisión completa, pero tras finalizar el tratamiento presenta infecciones respiratorias de duración prolongada y dos ingresos por neumonía. Señale el estudio complementario menos útil para reconocer y tratar una posible inmunodeficiencia secundaria:

- 1) Concentración de inmunoglobulinas (IgG, IgA, IgM) en sangre periférica.
- 2) Actividad bactericida de los fagocitos.
- 3) Recuento de poblaciones linfocitarias T y B circulantes.
- 4) Titulación de anticuerpos específicos *anti-neumococo* pre y post- vacunación.

Respuesta correcta: 2



P099 MIR 2018-2019

En la leucemia linfóide crónica NO es un marcador de mal pronóstico:

- 1) Hipermutaciones de IgVH.
- 2) Alta expresión de ZAP 70.
- 3) Mutaciones de TP53.
- 4) Alta expresión de CD38.

Respuesta correcta: 1

P105 MIR 2019-2020

Paciente de 67 años que, en los últimos 6 meses, en dos analíticas de rutina, presenta linfocitosis progresiva. En la última, hemoglobina 15,4 g/dL; leucocitos $18,5 \times 10^3/\text{mCL}$ con 82% de linfocitos maduros que por citometría de flujo expresan los antígenos CD5/CD19/CD23 y plaquetas $240 \times 10^3/\text{mCL}$. ¿Qué actitud le parece CORRECTA?

- 1) Estudio de mutaciones de TP53 para establecer el pronóstico.
- 2) Aspirado/biopsia ósea para confirmar el diagnóstico.
- 3) PET/CT para establecer la actitud terapéutica.
- 4) Nuevo control clínico y analítico en 6 meses.

Respuesta correcta: 4

P121 MIR 2022-2023

Varón de 68 años, portador de una válvula mecánica mitral, anticoagulado con acenocumarol, que presenta un INR de 9 en un control rutinario en su centro de salud. No tiene síntomas de sangrado en el momento actual. ¿Cuál de las siguientes es la actitud MÁS correcta?

- 1) Suspender el tratamiento con acenocumarol y administrar 10 mg de vitamina K en infusión intravenosa lenta, que se repetirá cada 12 horas si fuera necesario.
- 2) Suspender el acenocumarol y remitir al paciente a un centro hospitalario para vigilar la aparición de sangrado.
- 3) Suspender temporalmente el acenocumarol y reanudar la anticoagulación cuando se haya alcanzado el intervalo terapéutico, calculando de nuevo la dosis.
- 4) Iniciar la administración de concentrado de complejo de protrombina o plasma fresco congelado según el peso.

Respuesta correcta: 3

T10 Leucemias agudas

P108 MIR 2009-2010

Señale cuáles son las alteraciones citogenéticas de mal pronóstico en una leucemia mieloblástica:

- 1) t(15;17).
- 2) t(8;21).
- 3) Monosomía 5,7, cariotipo complejo.
- 4) Inversión cromosoma 16.
- 5) Trisomía 8.

Respuesta correcta: 3

P097 MIR 2011-2012

Una mujer de 43 años consulta a su médico de Atención Primaria por cansancio, gingivorragias y petequias. Se realiza analítica en la que destaca: anemia de 8 g/dL, trombopenia de 4.000/microlitro y leucopenia de 1.200/microlitro con neutropenia absoluta. En el estudio de coagulación se observa alargamiento del APTT (43"), actividad de la protrombina disminuida (55%), hipofibrinogenemia (98 mg/dL) y presencia de concentración elevada de dímero-D y monómeros de fibrina. Se remite para estudio hematológico urgente, realizándose un aspirado de médula ósea en el que se observa una infiltración masiva por elementos inmaduros con núcleo hendido y numerosas astillas y bastones de Auer en el citoplasma. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de esta paciente?

- 1) Leucemia mieloide crónica.
- 2) Leucemia aguda promielocítica.
- 3) Leucemia aguda monoblástica.
- 4) Leucemia linfóide crónica.
- 5) Leucemia linfóide aguda.

Respuesta correcta: 2

P106 MIR 2019-2020

Mujer de 65 años derivada a Urgencias por fiebre y alteraciones en la analítica: Hemoglobina 11,4 g/dL, leucocitos $0,86 \times 10^3/\text{mCL}$ (neutrófilos 41,9%, linfocitos 55,8%), plaquetas $48,0 \times 10^3/\text{mCL}$, fibrinógeno 118 mg/dL, dímero D 20,2 mcg/mL. Se realiza examen de médula ósea con la que se le diagnostica una leucemia

aguda con t(15;17) en el 60% de las células. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?

- 1) Si está asintomática se iniciará ácido transretinoico (ATRA) y se recomendarán controles en hospital de día.
- 2) Se iniciará tratamiento con trióxido de arsénico, ATRA y terapia de soporte.
- 3) Es una leucemia mieloblástica tipo M3, por lo que se iniciará tratamiento quimioterápico y heparina para controlar la coagulación intravascular diseminada.
- 4) Se debe iniciar tratamiento antibiótico. Cuando desaparezca la fiebre se iniciará el tratamiento de la leucemia.

Respuesta correcta: 2

P005 MIR 2020-2021

Pregunta vinculada a la imagen nº 5. Las células indiferenciadas (blastos) de la imagen vinculada son típicas, por sus granulaciones en forma de bastones alargados, de:

- 1) Mieloma secretor de IgA leucemizado.
- 2) Linfoma folicular leucemizado.
- 3) Leucemia aguda mieloide.
- 4) Leucemia aguda linfóide.

Respuesta correcta: 3

T11 Linfoma de Hodgkin

P212 MIR 2009-2010

¿Cuál será la conclusión más probable en una biopsia ganglionar cervical de un varón de 24 años con fiebre en la que el patólogo describe unas células grandes con amplio citoplasma, núcleos bilobulados y grandes nucleolos de tipo inclusión acompañadas de eosinófilos, células plasmáticas y ocasionales polimorfonucleares?

- 1) Infección viral de tipo *citomegalovirus*.
- 2) Linfoma de células grandes de posible línea T.
- 3) Mononucleosis infecciosa.
- 4) Reacción de tipo alérgico de causa desconocida.
- 5) Linfoma de Hodgkin.

Respuesta correcta: 5

P231 MIR 2009-2010

¿Cuál es la variedad histológica más frecuente de la enfermedad de Hodgkin?

- 1) Esclerosis nodular.
- 2) Predominio linfocítico.
- 3) Celularidad mixta.
- 4) Depleción linfóide.
- 5) Esclerosis mixta.

Respuesta correcta: 1

P108 MIR 2013-2014

El tratamiento de primera línea más adecuado en el linfoma de Hodgkin clásico en estadio IIA es:

- 1) Quimioterapia tipo CHOP (6 ciclos).
- 2) Quimioterapia tipo ABVD (2-4 ciclos), seguida de radioterapia en campo afecto.
- 3) Quimioterapia tipo ABVD (4 ciclos), seguida de trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos.
- 4) Radioterapia en campo ampliado (ej. tipo Mantle o tipo Y invertida).
- 5) Radioterapia en campos afectados.

Respuesta correcta: 2

P005 MIR 2016-2017

Pregunta vinculada a la imagen nº 5. Mujer de 25 años que presenta una adenopatía palpable e indolora en región supraclavicular. La enferma refiere que ha tenido periodos febriles. Se le practica biopsia de la adenopatía que se tiñe con hematoxilina-eosina. En el informe anatomopatológico se indica que la lesión muestra un componente de células grandes que expresan CD15 y CD30, pero no CD45, sobre un fondo de carácter inflamatorio. ¿Su diagnóstico es?

- 1) Toxoplasmosis.
- 2) Enfermedad de Hodgkin.
- 3) Mononucleosis infecciosa.
- 4) Enfermedad por arañazo de gato.

Respuesta correcta: 2

P008 MIR 2019-2020

Pregunta vinculada a la imagen nº 8. Mujer de 28 años sin antecedentes personales ni familiares de interés que consulta por

aparición de una masa supraclavicular izquierda sin otra sintomatología acompañante. Se le realiza analítica básica en la que únicamente destaca una LDH de 373 UI/L. Considerando los datos clínicos y la prueba de imagen (PET-TC con 18F-FDG) de la imagen vinculada, ¿qué diagnóstico es el MÁS probable?

- 1) Carcinoma tímico con diseminación a distancia.
- 2) Enfermedad asociada a IgG4.
- 3) Sarcoidosis.
- 4) Síndrome linfoproliferativo estadio IV.

Respuesta correcta: 4

P149 MIR 2023-2024

Con respecto a la PET-TC con 18F-fluorodesoxiglucosa (18F-FDG) en pacientes con linfoma, señale la respuesta INCORRECTA:

- 1) Es más exacta para la valoración de la médula ósea en el linfoma de Hodgkin (LH).
- 2) Realizada a mitad de tratamiento en el LH ayuda a decidir la duración del mismo.
- 3) Es útil en los linfomas no Hodgkin de bajo grado.
- 4) Al final del tratamiento puede diferenciar entre enfermedad residual y enfermedad activa.

Respuesta correcta: 3

T12 Linfomas no Hodgkin

P110 MIR 2009-2010

De todos los siguientes, ¿Cuál es el parámetro con mayor valor pronóstico en los linfomas de células grandes?

- 1) VSG.
- 2) Tasa sérica de LDH.
- 3) Masas tumorales > 10 cm.
- 4) Número de zonas afectas según PET/TAC.
- 5) Alteraciones citogenéticas.

Respuesta correcta: 2

P098 MIR 2011-2012

Entre los linfomas que se citan a continuación ¿Cuál de ellos se presenta con mayor frecuencia en nuestro medio?

- 1) Linfoma de zona marginal tipo MALT.
- 2) Linfoma linfoplasmacítico.
- 3) Linfoma difuso de células grandes B.
- 4) Linfoma de células del manto.
- 5) Linfoma linfoblástico de células B precursoras.

Respuesta correcta: 3

P099 MIR 2011-2012

La alteración genética característica del linfoma de Burkitt es la traslocación t(8;14). ¿Qué oncogén se activa mediante esta traslocación?

- 1) BCL-2.
- 2) c-MYC.
- 3) Ciclina D1.
- 4) MAF.
- 5) BCL-6.

Respuesta correcta: 2

P097 MIR 2012-2013

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto a los linfomas de la zona marginal tipo MALT gástrico?

- 1) Se presentan frecuentemente con grandes masas adenopáticas diseminadas.
- 2) Algunos casos se curan con tratamiento antibiótico.
- 3) La cirugía radical es el tratamiento de elección hoy día.
- 4) Presentan un curso clínico agresivo.
- 5) Se caracterizan por el reordenamiento del gen BCL-1.

Respuesta correcta: 2

P021 MIR 2014-2015

Paciente de 49 años sin antecedentes de interés. Refiere historia de 2 semanas de evolución de dolor abdominal difuso independiente de la ingesta y la deposición y acompañado de vómitos ocasionales malestar general y sudoración profusa. Analítica: Hb 12 gr/dl. Leucocitos $10 \times 10^9/L$ (Neutrófilos 80%, Linfocitos 15%, Monocitos 3%, Eosinófilos 1%). Plaquetas $270 \times 10^9/L$. Glucosa 100 mg/dl, Urea 80 mg/dl, Creatinina 1,5 mg/dl, A. Úrico 12 mg/dl, LDH 7800 UI/L; GOT, GPT y fosfatasa alcalina normales. TAC: Gran masa (16 cm) en re-



troperitoneo que infiltra páncreas, asas del intestino delgado y riñón derecho. La biopsia es la que se muestra en la imagen. Inmunohistoquímica: CD20 (+), CD 3(-), bcl 2 (-), CD10+, bcl 6 (+), p53 (-), TDT (-), MIB1 (índice de proliferación) 100%. Genética: reordenamiento del 8q24, gen c-myc. ¿Cuál es el diagnóstico?

- 1) Linfoma difuso B de célula grande.
- 2) Linfoma linfocítico.
- 3) Linfoma Folicular 3b.
- 4) Linfoma T de tipo intestinal.
- 5) Linfoma de Burkitt.

Respuesta correcta: 5

P022 MIR 2014-2015

Pregunta vinculada a la imagen nº 11. ¿Qué tratamiento es el más adecuado en el paciente anterior?

- 1) Cirugía citorreductora seguido de quimioterapia tipo Rituximab-CHOP hasta remisión completa.
- 2) Rituximab-CHOP / 21 x 6-8 ciclos seguido de Radioterapia del retroperitoneo.
- 3) Rituximab-CHOP /21 x 6-8 ciclos seguido de QT intensiva y trasplante de stem-cell (TASPE).
- 4) Quimioterapia intensiva que incluya Rituximab, dosis altas de Ciclofosfamida y profilaxis de SNC.
- 5) Retrasar tratamiento hasta obtener PET-TAC y luego tratar con Rituximab-CHOP /14 x 6-8 ciclos.

Respuesta correcta: 4

P176 MIR 2015-2016

Mujer de 78 años con antecedentes de diabetes tipo 2 en tratamiento con antidiabéticos orales, HTA en tratamiento con betabloqueantes e inhibidores de la ECA, e insuficiencia cardiaca congestiva grado 1 de la NYHA, con FEVI del 48%, y actualmente asintomática. Estado funcional: ECOG 0. Historia de 2 años de evolución de pequeños bultos en el cuello. Biopsia de adenopatía cervical: linfoma folicular grado 2. Estudio de extensión: Hb 12 gr/dL, Leucocitos 6.900/mcL (Neutrófilos 60%, Linfocitos 27%, Monocitos 6%, Eosinófilos 4%, Basófilos 4%) Plaquetas 220.000/ mcL. MO: infil-

trada por Linfoma folicular. Creatinina 1,5 mg/dL, LDH 235 U/L, Beta-2 microglobulina 2,1 mcg/mL. TAC: adenopatías menores de 3 cm en territorios cervical, axilar, retroperitoneo, ilíacos e inguinales; hígado y bazo normales. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es el más apropiado?

- 1) Rituximab-CHOP (Ciclofosfamida, Adriamici-
cina, Vincristina, Prednisona).
- 2) Rituximab-CVP (Ciclofosfamida, Vincristi-
na, Prednisona).
- 3) No tratar y vigilar (espera y ver).
- 4) Rituximab-Bendamustina.

Respuesta correcta: 3

P100 MIR 2018-2019

Con respecto al tratamiento del linfoma folicular, una de las siguientes aseveraciones es FALSA. Señálela:

- 1) El tratamiento de mantenimiento con rituximab prolonga la duración de las remisiones.
- 2) En la era de la inmunoterapia, la actitud de observación sin tratamiento no es adecuada en este subtipo de linfoma.
- 3) La combinación de rituximab y CHOP consigue la remisión en un elevado porcentaje de pacientes.
- 4) El trasplante de células madre hematopoyéticas puede ser útil tras las recaídas.

Respuesta correcta: 2

P108 MIR 2019-2020

En relación con el linfoma folicular, señale la afirmación INCORRECTA:

- 1) Es el segundo linfoma más frecuente en Occidente.
- 2) Las células neoplásicas derivan de un linfocito de la médula ósea.
- 3) Puede transformarse en un linfoma B difuso de célula grande.
- 4) Puede permanecer años sin necesitar tratamiento.

Respuesta correcta: 2

P161 MIR 2021-2022

En el diagnóstico de un proceso linfoproliferativo es fundamental el estudio mole-

cular y del inmunofenotipo. La detección de la translocación 11:14 con afectación de la ciclina D1 es característica de un:

- 1) Linfoma folicular.
- 2) Linfoma de la zona marginal.
- 3) Linfoma linfoblástico.
- 4) Linfoma del manto.

Respuesta correcta: 4

P204 MIR 2022-2023

El síndrome de lisis tumoral, frecuente en neoplasias hematológicas, se caracteriza por las siguientes complicaciones, EXCEPTO:

- 1) Hipercalcemia.
- 2) Hiperuricemia.
- 3) Hiperfosfatemia.
- 4) Uremia.

Respuesta correcta: 1

P196 MIR 2023-2024

Paciente de 65 años con leucemia linfoblástica aguda que acude a urgencias por presentar tras una sesión de quimioterapia hace 48 h un cuadro de náuseas, vómitos, irritabilidad neuromuscular, alteración del nivel de conciencia, fracaso renal agudo, hiperuricemia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. El diagnóstico inicial de sospecha más probable es:

- 1) Sepsis en paciente inmunodeprimido.
- 2) Síndrome de lisis tumoral.
- 3) Hipocalcemia por citostáticos.
- 4) Alteración metabólica secundaria a la hiperemesis postquimioterapia.

Respuesta correcta: 2

P144 MIR 2024-2025

Hombre de 48 años, exfumador hasta el 2.020, con antecedente de nefrectomía parcial izquierda en el 2.020 por carcinoma de células renales, tipo célula clara, grado 2/4, pT1b, que acude por autopalparse una adenopatía laterocervical alta hace 4 meses. En la ecografía de cuello se identifican 2 lesiones nodulares submaxilares y en el TC de cuello se informa de una lesión nodular de partes blandas derecha que corresponde probablemente a una ade-

nopatía sospechosa. Se indica biopsia de la lesión donde se observa una proliferación neoplásica constituida por células con marcada atipia citológica que se disponen con un patrón de crecimiento difuso. El estudio inmunohistoquímico es positivo para CD20, y negativo para CD3, CD30, CD15 y CKAE1-AE3. En estos casos se completa el estudio con CD10, Bcl6 y MUM1 para indicar el fenotipo de la neoplasia. ¿Cuál es el diagnóstico anatomopatológico?

- 1) Linfoma Hodgkin variante clásica.
- 2) Linfoma B difuso de célula grande.
- 3) Linfoma T periférico.
- 4) Metástasis de carcinoma.

Respuesta correcta: 2

P147 MIR 2024-2025

Los siguientes tipos de linfoma pueden ser originados por virus. ¿Cuál de ellos es producido por el virus herpes humano tipo 8 (KSHV/HHV8)?

- 1) Leucemia-linfoma T del adulto.
- 2) Linfoma primario de cavidades.
- 3) Linfoma de Burkitt.
- 4) Granulomatosis linfomatoide.

Respuesta correcta: 2

T13

Mieloma múltiple y otras neoplasias de las células plasmáticas

P031 MIR 2012-2013

Pregunta vinculada a la imagen nº 16. En la radiografía de la imagen nº 16 se observa:

- 1) Lesiones líticas.
- 2) Lesiones blásticas.
- 3) Alteraciones en sal y pimienta.
- 4) Hiperostosis focal.
- 5) Craneoestenosis.

Respuesta correcta: 1

P032 MIR 2012-2013

Pregunta vinculada a la imagen nº 16. ¿Cuál de entre los siguientes es su diagnóstico?

- 1) Hiperparatiroidismo.
- 2) Acromegalia.
- 3) Enfermedad de Paget.
- 4) Mieloma.
- 5) Hipervitaminosis D.

Respuesta correcta: 4

P099 MIR 2012-2013

En la macroglobulinemia de Waldenström se producen todas las manifestaciones que se indican EXCEPTO una:

- 1) Lesiones osteolíticas.
- 2) Proliferación de linfoplasmas.
- 3) Componente monoclonal IgM.
- 4) Hiperviscosidad.
- 5) Adenopatías y esplenomegalia.

Respuesta correcta: 1

P106 MIR 2013-2014

Acude al Servicio de Urgencias un hombre de 72 años con fractura patológica en fémur izquierdo. Tras la intervención quirúrgica, se realiza un estudio diagnóstico para averiguar la patología subyacente con los siguientes hallazgos: hemoglobina 9,5 g/dL, proteínas totales 11 g/dL, (VN: 6-8 g/dL), albúmina sérica 2 g/dL, (VN 3.5-5,0 g/dL), beta 2 microglobulina 6 mg/L (VN 1,1-2,4 mg/L), creatinina sérica 1,8 mg/dL (VN: 0,1-1,4 mg/dL). Indique cuáles serían las pruebas diagnósticas necesarias para confirmar el diagnóstico más probable:

- 1) Serie ósea radiológica y aspirado de médula ósea.
- 2) Electroforesis sérica y urinaria y pruebas de función renal.
- 3) Aspirado de médula ósea y concentración de calcio sérico.
- 4) Aspirado de médula ósea y electroforesis sérica y urinaria.
- 5) Biopsia de la fractura patológica y serie ósea radiológica.

Respuesta correcta: 4

P231 MIR 2013-2014

Todas las siguientes enfermedades se pueden acompañar de esplenomegalia palpable, EXCEPTO una. Indique esta última:

- 1) Linfoma no Hodgkin.
- 2) Mieloma múltiple.
- 3) Tricoleucemia.
- 4) Enfermedad de Gaucher.
- 5) Mielofibrosis con metaplasia mieloide.

Respuesta correcta: 2

P082 MIR 2014-2015

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA con respecto al mieloma múltiple?

- 1) Son datos importantes para el pronóstico la citogenética y los niveles séricos de albúmina y beta-2-microglobulina.
- 2) El bortezomib, la talidomida, la lenalidomida y la poliquimioterapia son herramientas terapéuticas muy útiles.
- 3) El trasplante autogénico de progenitores hematopoyéticos proporciona una larga supervivencia libre de progresión.
- 4) El trasplante alogénico se debe considerar un procedimiento experimental (de eficacia no probada).
- 5) La radioterapia no tiene ningún papel en el tratamiento de la enfermedad o sus complicaciones.

Respuesta correcta: 5

P101 MIR 2016-2017

Hombre de 72 años de edad que refiere clínica de dolor lumbar y astenia en las últimas semanas. En la analítica se objetiva Hb de 10 g/dL, VCM 82 fL, VSG 110 mm/h, creatinina de 2,5 mg/dL y proteinuria de cadenas ligeras Kappa de 4,5 g en orina de 24 horas. En el aspirado medular se observó una infiltración del 45% de células plasmáticas indiferenciadas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación con el tratamiento recomendado en este paciente?

- 1) El tratamiento dependerá del resultado del estudio citogenético.
- 2) Tras la terapia inicial de inducción, la edad del paciente es adecuada para realizar posteriormente un trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica como terapia de intensificación.
- 3) El tratamiento más apropiado de inducción debe incluir un esquema de tres fármacos por ejemplo bortezomib junto con melfalán y prednisona.



- 4) El tratamiento de primera línea en este paciente ha de ser necesariamente lenalidomida oral debido a la edad y a la insuficiencia renal.

Respuesta correcta: 3

P110 MIR 2017-2018

Mujer de 64 años, con antecedente de túnel carpiano bilateral, que presenta en los últimos meses un cuadro de astenia y disnea progresiva, hasta hacerse de pequeños esfuerzos. En la analítica destaca un pro-BNP de 2.500 pg/mL, así como la existencia de un componente monoclonal (inmunofijación positiva para cadenas lambda) en suero de 0,4 g/dL. Los niveles de cadenas ligeras libres kappa y lambda son 1,2 y 67,8 mg/dL, respectivamente. Se realiza una punción esternal, observándose una plasmocitosis medular del 6%. Ausencia de lesiones líticas en TC de esqueleto entero. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha y la prueba diagnóstica INICIAL para su confirmación?

- 1) Macroglobulinemia de Waldenström - Análisis molecular del gen MYD88.
- 2) Mieloma múltiple sintomático - PET/TC.
- 3) Amiloidosis AL - Aspirado/biopsia de grasa abdominal.
- 4) Síndrome POEMS - Determinación de VEGF.

Respuesta correcta: 3

T14 Hemostasia. Generalidades

P224 MIR 2010-2011

En condiciones de salud las células endoteliales vasculares dificultan la formación de trombos a través de la producción de las siguientes sustancias EXCEPTO:

- 1) Angiotensina II.
- 2) Prostaciclina.
- 3) Glucosaminoglucano de heparín-sulfato.
- 4) Trombomodulina.
- 5) Óxido nítrico.

Respuesta correcta: 1

P026 MIR 2021-2022

¿Cuál de los siguientes estudios de la coagulación se encontraría alterado en un paciente en el que se sospecha de un trastorno hemorrágico hereditario por deficiencia del factor VII?

- 1) Tiempo de tromboplastina parcial activado.
- 2) Tiempo de trombina.
- 3) Tiempo de protrombina.
- 4) Determinación de factor Von Willebrand.

Respuesta correcta: 3

P138 MIR 2025-2026

Varón de 80 años con gonartrosis. Acude a estudio preoperatorio previo a prótesis de la rodilla derecha. Su hemograma es normal. Los tests de coagulación muestran INR:1, tiempo de cefalina-caolín 47'' (valor normal 27-37). La agregación plaquetaria con ristocetina está ligeramente alterada, pero es normal con colágeno y ADP. El paciente no refiere ninguna clínica hemorrágica. ¿Cuál es la causa de esta alteración en las pruebas de coagulación?

- 1) Heterocigosis para hemofilia A.
- 2) Enfermedad de von Willebrand tipo I.
- 3) Anticoagulante lúpico.
- 4) Síndrome de Bernard-Soulier.

Respuesta correcta: 2

T15 Alteraciones plaquetarias

P105 MIR 2009-2010

Hombre de 55 años que consulta por crisis convulsiva generalizada. En la analítica destaca: hemoglobina: 8 g/dL, volumen corpuscular medio: 98 fL, reticulocitos: 5%, leucocitos 7.500/mm³, plaquetas 95.000/mm³, creatinina: 5 mg/dL, bilirrubina total: 5 mg/dL (directa: 1,1 mg/dL), LDH: 1550 U/L. En la extensión de sangre periférica se observan abundantes hematíes fragmentados. Estudio de coagulación: actividad de protrombina: 95%, TTPa (tiempo parcial de tromboplastina activada) ratio: 1. En la tomografía axial computadorizada craneal no existen lesiones cerebrales. El diagnóstico más probable sería:

- 1) Déficit de glucosa 6 fosfato-deshidrogenasa.
- 2) Anemia hemolítica autoinmunitaria.
- 3) Púrpura trombocitopénica trombótica.
- 4) Coagulación intravascular diseminada.
- 5) Hemoglobinuria paroxística nocturna.

Respuesta correcta: 3

P019 MIR 2010-2011

Pregunta vinculada a la imagen nº 10. Un paciente de 52 años es derivado para estudio al hospital desde un centro de atención primaria donde consultó por clínica de astenia y fatigabilidad fácil. El paciente bebe unos 80 g de alcohol al día, refiere episodios de epistaxis con cierta asiduidad y ha tenido dos accidentes de tránsito con fracturas diversas. La exploración física muestra una palidez de piel y conjuntivas y múltiples lesiones en cara, manos, labios y mucosa oral, cuyo detalle puede observarse en la imagen 10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sería la más CORRECTA?

- 1) Las lesiones son muy sugestivas de una púrpura de Schönlein-Henoch.
- 2) El diagnóstico diferencial deberá incluir las arañas vasculares propias de una cirrosis hepática alcohólica.
- 3) El examen hematológico característicamente mostrará esquistocitos y plaquetopenia.
- 4) Lo más probable es que el paciente presente una anemia por pérdidas digestivas debidas a un pólipo degenerado en el colon.
- 5) Las lesiones mucosas son muy inespecíficas y difícilmente pueden relacionarse con la sintomatología que refiere el paciente.

Respuesta correcta: 2

P020 MIR 2010-2011

Pregunta vinculada a la imagen nº 10. Supongamos que se establece el diagnóstico de presunción de una enfermedad autosómica dominante en la que se ven implicados diversos genes relacionados con el remodelado vascular y la angiogénesis. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones parece más apropiada?

- 1) Se aconseja que todos los pacientes con esta sospecha diagnóstica se sometan a una prueba de imagen para descartar un aneurisma de aorta.

- 2) La causa de muerte más frecuente, a menos de que se haga un tratamiento preventivo específico, es la hemorragia cerebral.
- 3) El sustrato anatomopatológico es de vasculitis leucocitoclástica con necrosis fibrinoide en los pequeños vasos dérmicos.
- 4) Es relativamente frecuente que estos pacientes desarrollen una anemia ferropénica. En este caso, la causa más frecuente es la hemorragia digestiva.
- 5) A pesar de que en este caso había anemia, es posible que estos pacientes desarrollen poliglobulia hipoxémica por fístulas pulmonares.

Respuesta correcta: 5

P084 MIR 2010-2011

En cuál de las siguientes circunstancias está indicada la transfusión de unidades de plaquetas en un paciente con púrpura trombocitopénica idiopática (PTI):

- 1) 11.000 plaquetas/mm³, melenas, Hb 10 g/dL, VCM 85 fL, TA 85/60 mmHg, FC 115 lpm.
- 2) 7.000 plaquetas/mm³, púrpura en extremidades inferiores, Hb 13 g/dL, FC 90 lpm, TA 150/85 mmHg.
- 3) 5.000 plaquetas/mm³, Hb 12 g/dL, VCM 85 fL, TA 120/60 mmHg, FC 80 lpm.
- 4) 80.000 plaquetas/mm³, Hb 8,5 g/dL, VCM 71 fL, FC 85 lpm, TA 110/60 mmHg.
- 5) 50.000 plaquetas/mm³, epistaxis, Hb 13 g/dL, TA 130/60 mmHg, FC 70 lpm.

Respuesta correcta: 1

P096 MIR 2010-2011

Mujer con historia personal familiar de sangrado por mucosas. El estudio de coagulación presenta un tiempo de hemorragia y tiempo de tromboplastina parcial activado alargados. Actividad de protrombina del 100%. ¿Qué patología de la coagulación le sugieren estos datos?

- 1) Enfermedad de Von Willebrand.
- 2) Hemofilia A.
- 3) Déficit de factor XI.
- 4) Hemofilia B.
- 5) Déficit de factor VII.

Respuesta correcta: 1

P217 MIR 2011-2012

¿En cuál de las siguientes patologías se incluye el tratamiento con gammaglobulinas humanas?

- 1) Alergia al veneno de abeja.
- 2) Rechazo cardíaco.
- 3) Angioedema hereditario.
- 4) Púrpura trombocitopénica idiopática.
- 5) Osteoartritis.

Respuesta correcta: 4

P098 MIR 2012-2013

Una mujer de 33 años consulta por epistaxis de repetición, petequias y equimosis. Las pruebas de laboratorio muestran trombocitopenia con un recuento plaquetario de 4000 plaquetas/microlitro. El diagnóstico de presunción inicial es de púrpura trombocitopénica inmunitaria crónica (PTI). ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA respecto al diagnóstico de PTI?

- 1) La presencia de adenopatías o esplenomegalia en la exploración física sugiere un diagnóstico diferente de PTI.
- 2) El análisis de médula ósea muestra un número disminuido de megacariocitos, sin otras alteraciones.
- 3) El hemograma completo muestra trombocitopenia aislada con plaquetas a menudo grandes, sin anemia, salvo que exista una hemorragia importante o hemólisis autoinmune asociada (síndrome de Evans).
- 4) El diagnóstico de PTI se establece por exclusión de otros procesos causantes de trombocitopenia.
- 5) La determinación de anticuerpos antiplaquetarios no es precisa para establecer el diagnóstico.

Respuesta correcta: 2

P104 MIR 2013-2014

Una paciente de 67 años, en tratamiento con ticlopidina, acude a urgencias con cefalea, astenia y petequias en extremidades inferiores. En la analítica presenta hemoglobina 8,2 g/dL, VCM 100 fL, plaquetas 25000/μL y leucocitos 7500/μL con fórmula normal. La cifra de reticulocitos está elevada y en el frotis de sangre

se observa numerosos esquistocitos. Los estudios de coagulación (TTPA, TP y fibrinógeno) son normales. En la bioquímica destaca LDH 2700 UI/L y bilirrubina 2,6 mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de la paciente?

- 1) Púrpura trombocitopénica autoinmune.
- 2) Púrpura trombótica trombocitopénica.
- 3) Aplasia medular.
- 4) Trombocitopenia inducida por fármacos.
- 5) Coagulación intravascular diseminada.

Respuesta correcta: 2

P109 MIR 2013-2014

Muchacha de 19 años, sin antecedentes médicos de interés, salvo un cuadro gripal autolimitado 3 semanas antes, que acude al servicio de Urgencias por petequias y equimosis de aparición espontánea. En la exploración física, la paciente se encuentra con buen estado general, afebril, normotensa y orientada en tiempo y espacio. Se observan petequias diseminadas por EEII y abdomen y equimosis pequeñas en zonas de decúbito. No se palpan adenopatías ni esplenomegalia. La analítica realizada ofrece los siguientes hallazgos: Hb 12,6 g/dL, leucocitos 5.500/mm³, plaquetas 7.000/mm³. El estudio del frotis de sangre periférica ofrece una morfología eritrocitaria normal, recuento leucocitario diferencial normal y el recuento plaquetario es concordante con la cifra del autoanalizador, sin observarse agregados plaquetarios. Bioquímica, proteinograma, beta 2 microglobulina y LDH normales. ¿Cuál cree que es, de los siguientes, el tratamiento inicial más adecuado?

- 1) Transfusión de plaquetas.
- 2) Rituximab en pauta semanal.
- 3) Ciclofosfamida en pulsos de 4 días cada 21 días.
- 4) Plasmaféresis diaria.
- 5) Prednisona, 1 mg/día durante 2-3 semanas.

Respuesta correcta: 5

P079 MIR 2014-2015

Mujer de 35 años de edad en tratamiento hormonal por infertilidad. Acude a Urgencias por síndrome constitucional y parestesias en hemicuerpo izquierdo. En



análisis de sangre se detecta: Hb 7,5 g/dL, reticulocitos 10% (0,5-2%), plaquetas 5.000/ μ L, leucocitos normales, LDH 1.200 UI/L, test de Coombs directo negativo, haptoglobina indetectable. Morfología de sangre periférica con abundantes esquistocitos. Pruebas de coagulación normales. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica y el tratamiento más adecuado?

- 1) Anemia hemolítica autoinmune. Iniciar esteroides.
- 2) Enfermedad de von Willebrand. Administración de desmopresina.
- 3) Púrpura trombocitopénica. Iniciar esteroides y transfusión de plaquetas.
- 4) Síndrome de Evans. Iniciar esteroides.
- 5) Púrpura trombótica trombocitopénica. Tratamiento con plasmaféresis.

Respuesta correcta: 5

P081 MIR 2014-2015

Mujer de 29 años de edad con antecedentes de reglas abundantes y anemia ferropénica de larga evolución que ha precisado tratamiento con ferroterapia desde los 17 años. Consulta porque tras una extracción dental tiene hemorragia que ha precisado tratamiento hemostático local. Relata que una tía materna presenta epistaxis frecuentes. En analítica presenta: 8.000 leucocitos/ μ L, Hb 10,7 g/dL, VCM 76 fl, 380.000 plaquetas/ μ L; la bioquímica es normal. Actividad de protrombina 90%; INR 0,9; Tiempo de Tromboplastina Parcial Activado (TPPA) 48 s (39 s) con un TPPA ratio de 1,3 y fibrinógeno derivado 340 mg/dL. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica más probable y cómo lo confirmaría?

- 1) Hemofilia A y prueba de mezclas.
- 2) Anticoagulante lúpico y estudio de AMAS.
- 3) Anemia sideroblástica y aspirado medular.
- 4) Trombocitopatía congénita y estudio de agregación plaquetaria.
- 5) Enfermedad de von Willebrand determinación de factor vW.

Respuesta correcta: 5

P083 MIR 2014-2015

Paciente de 74 años de edad, asintomático, que en una analítica de rutina presenta plaquetas 40.000 plaquetas/ μ L, siendo

el resto del hemograma normal y la bioquímica completa normal. Señale la respuesta CORRECTA:

- 1) El diagnóstico más probable es una Púrpura Trombocitopénica Idiopática y se debe iniciar tratamiento esteroideo lo antes posible.
- 2) Se trata de una trombopenia grave con alto riesgo de sangrados espontáneos.
- 3) Se debería realizar un frotis de sangre periférica para descartar una pseudotrombocitopenia o trombopenia espúrea antes de realizar medidas adicionales.
- 4) El diagnóstico más probable es el de un síndrome mielodisplásico, por lo que la prueba a realizar sería un estudio de médula ósea.
- 5) Se debe realizar 1 estudio inicial con serologías virales estudio de autoinmunidad y ecografía abdominal. Si todas estas pruebas fueran normales se debería completar el estudio con un frotis de sangre periférica.

Respuesta correcta: 3

P096 MIR 2015-2016

Una mujer de 25 años acude al servicio de Urgencias por presentar en los últimos días equimosis y petequias en extremidades inferiores, así como gingivorragia. En el hemograma, presenta los siguientes datos: Hb 13 g/dL, leucocitos 8.500/ μ L con fórmula leucocitaria normal y plaquetas 9.000/ μ L. La determinación de los tiempos de coagulación es normal. ¿Cuál de las siguientes pruebas diagnósticas NO es preciso realizar?

- 1) Mutación JAK-2.
- 2) Aspirado de médula ósea.
- 3) Anticuerpos antinucleares.
- 4) Frotis de sangre periférica.

Respuesta correcta: 1

P099 MIR 2016-2017

Mujer afrocaribeña de 47 años sin antecedentes de interés que acude a urgencias por fiebre, astenia, malestar general, visión borrosa y disestesias en hemicuerpo izquierdo. La exploración física es normal. En la analítica destaca anemia (Hb 9 g/dL), trombopenia grave (plaquetas 16.000/ μ L) y elevación marcada de LDH. Respecto a este caso la respuesta CORRECTA es:

- 1) La primera sospecha es una anemia hemolítica autoinmune y la prueba más importante para el diagnóstico será un Coombs directo.
- 2) La primera sospecha es un cuadro de microangiopatía tipo púrpura trombótica trombocitopénica, y se debe realizar un frotis de sangre periférica.
- 3) La primera sospecha es un cuadro de microangiopatía tipo púrpura trombótica trombocitopénica, y se deben determinar unos niveles de ADAMTS 13 y hasta que no se tenga un resultado concluyente no se debería empezar tratamiento.
- 4) La primera sospecha es una púrpura trombocitopénica autoinmune con sangrado cerebral y anemización secundaria. Se deben determinar anticuerpos antiplaquetarios para orientar el tratamiento.

Respuesta correcta: 2

P111 MIR 2017-2018

Mujer de 17 años que presenta desde la primera menstruación reglas muy abundantes. Refiere epistaxis frecuentes. Hematimetría: Hb 10,5 g/dL, VCM 77 fL, leucocitos 7.200/ μ L con fórmula normal, plaquetas 182.000/ μ L. Tiempo de protrombina 12" (12"), TTPa 34" (30"), fibrinógeno 340 mg/dL. Agregación plaquetaria con ADP, colágeno y epinefrina: ausencia de respuesta. Aglutina con ristocetina. En citometría se observa ausencia de Gp IIb-IIIa. ¿Cuál es el diagnóstico?

- 1) Tromboastenia de Glanzmann.
- 2) Enfermedad de von Willebrand.
- 3) Trombocitopenia inmune primaria.
- 4) Síndrome de Bernard-Soulier.

Respuesta correcta: 1

P112 MIR 2017-2018

Una joven de 23 años es referida por su obstetra para estudio de trombocitopenia. Sus plaquetas en la primera evaluación prenatal hace un mes fueron de 42.000/ μ L. Está embarazada de 16 semanas y no refiere manifestaciones hemorrágicas. La exploración física es normal. Hemograma: leucocitos 8.500/ μ L, Hb 12 g/dL, plaquetas 51.000/ μ L. La revisión del frotis sanguíneo revela plaquetas en acúmulos. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica?

- 1) Trombocitopenia inmune primaria.
- 2) Trombocitopenia del embarazo.
- 3) Pseudotrombocitopenia por EDTA.
- 4) Púrpura trombótica trombocitopénica.

Respuesta correcta: 3

P107 MIR 2019-2020

Paciente de 18 años que acude a Urgencias con epistaxis de varios días de evolución, sin antecedentes personales ni familiares de interés. En la exploración está afebril, se observan equimosis múltiples, no se palpa esplenomegalia. Analítica: Leucocitos $7,2 \times 10^3/\text{mCL}$, Hb $12,3 \text{ g/dL}$, Plaquetas $6,0 \times 10^3/\text{mCL}$. La trombocitopenia se confirma en el frotis, donde se observan plaquetas de tamaño aumentado. Estudio de coagulación y bioquímica normales. ¿Cuál considera el diagnóstico más probable?

- 1) Púrpura trombótica trombocitopénica.
- 2) Coagulación intravascular diseminada.
- 3) Trombocitopenia inducida por infección.
- 4) Trombocitopenia inmune primaria.

Respuesta correcta: 4

P160 MIR 2021-2022

Mujer de 35 años, que toma anticonceptivos, acude a Urgencias con síndrome febril y parestesias en hemicuerpo izquierdo. En la analítica de sangre se observan Hb $7,5 \text{ g/dL}$, plaquetas $7.000/\text{mCL}$, leucocitos normales con recuento diferencial normal, LDH 1.200 UI/L , reticulocitos 10% (normal 0,5-2%), haptoglobina en suero indetectable, test de Coombs directo negativo y frotis de sangre periférica con esquistocitos. Coagulación (tiempo de protrombina y APTT) normal. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico MÁS probable?

- 1) Anemia hemolítica autoinmune.
- 2) Púrpura trombótica trombocitopénica.
- 3) Síndrome de Evans (anemia hemolítica y trombopenia inmunes).
- 4) Trombocitopenia inmune idiopática.

Respuesta correcta: 2

P147 MIR 2022-2023

Varón de 19 años, asintomático, que presenta en una analítica preoperatoria una trombopenia (plaquetas $43 \times 10^9/\text{L}$) con

niveles de hemoglobina y leucocitos normales. ¿Cuál de las siguientes actuaciones hay que realizar en PRIMER lugar?

- 1) Iniciar tratamiento con prednisona vía oral.
- 2) Realizar una biopsia de médula ósea para ver si la trombopenia es de origen central o periférico.
- 3) Realizar un examen morfológico del frotis sanguíneo para descartar la presencia de agregados plaquetarios inducidos por el anticoagulante.
- 4) Transfundir un concentrado de plaquetas para evitar un problema hemorrágico.

Respuesta correcta: 3

P146 MIR 2024-2025

Hombre de 76 años que es intervenido por recambio protésico de cadera derecha tras traumatismo. Entre los antecedentes personales destaca hipertensión arterial en tratamiento farmacológico y recambio protésico de rodilla izquierda hace tres meses por artrosis evolucionada. Al cuarto día del postoperatorio se detecta trombopenia de $52.000/\text{mm}$ con cifras de hemoglobina y leucocitos normales. El estudio de coagulación y la bioquímica es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- 1) Púrpura trombótica trombocitopénica.
- 2) Coagulación intravascular diseminada.
- 3) Trombopenia inducida por heparina.
- 4) Síndrome hemolítico urémico.

Respuesta correcta: 3

T16

Alteraciones de la coagulación sanguínea

P106 MIR 2009-2010

¿Cuál de las siguientes NO es una manifestación hemorrágica de la hemofilia?

- 1) Epistaxis.
- 2) Hemartros.
- 3) Equimosis.
- 4) Hemorragias musculares.
- 5) Petequias.

Respuesta correcta: 5

P101 MIR 2011-2012

Mujer de 25 años de edad que acude a consulta porque desea quedar embarazada y quiere saber qué tratamiento debe realizar durante el eventual embarazo, ya que es portadora del Factor V Leiden en heterocigosis. Nunca ha tenido ningún fenómeno trombótico. Se realizó la determinación del mencionado factor como estudio familiar tras un episodio de embolia del pulmón en un hermano. ¿Qué tratamiento se debe aconsejar?

- 1) Dado que la gestación es un estado pro-trombótico, existiría alto riesgo de tromboembolia venosa por lo que se debe desaconsejar el embarazo.
- 2) Se debe realizar tratamiento con heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas en el puerperio inmediato siendo opcional realizar igual tratamiento durante el embarazo.
- 3) El Factor V Leiden en heterocigosis es una trombofilia de bajo riesgo y no hay necesidad de ningún tratamiento en el embarazo y puerperio.
- 4) Se debe aconsejar aspirina a bajas dosis durante todo el embarazo y puerperio.
- 5) Debe realizar tratamiento con fármacos anti vitamina K (acenocumarol) durante el embarazo.

Respuesta correcta: 2

P094 MIR 2012-2013

Niño de 18 meses de edad, con calendario vacunal completo hasta la fecha, que consulta en el Servicio de urgencias por tumefacción de la rodilla derecha tras jugar en el parque, sin traumatismo evidente. En la anamnesis dirigida, la madre refiere que un tío de ella tenía problemas similares. La exploración ecográfica es compatible con hemartros y en la analítica que se realiza sólo destaca un alargamiento del APTT de 52" (normal 25-35"). ¿Cuál es la hipótesis diagnóstica más probable?

- 1) Síndrome de Marfan.
- 2) Enfermedad de Von Willebrand.
- 3) Enfermedad de Ehlers-Danlos.
- 4) Hemofilia A.
- 5) Enfermedad de Bernard-Soulier.

Respuesta correcta: 4



P175 MIR 2014-2015

Un recién nacido prematuro presenta a los 2 días de vida un cuadro de mal estado general, petequias y equimosis subcutáneas y sangrado persistente por las zonas de punción. La radiografía de tórax es compatible con una hemorragia pulmonar. En el estudio de coagulación los tiempos de protrombina y parcial de tromboplastina están alargados. El recuento de plaquetas es de 105.000/ μ L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- 1) Coagulación intravascular diseminada secundaria a una sepsis neonatal.
- 2) Trombocitopenia neonatal autoinmunitaria.
- 3) Trombocitopenia neonatal aloinmunitaria.
- 4) Enfermedad hemorrágica del recién nacido por déficit de vitamina K.
- 5) Hemorragia neonatal por disfunción plaquetaria.

Respuesta correcta: 1

P092 MIR 2015-2016

¿Cuál de las siguientes alteraciones justifica una prolongación del tiempo de protrombina, con normalidad del tiempo de tromboplastina parcial activada, y que se corrige tras la incubación con plasma normal?

- 1) Deficiencia de factor V.
- 2) Deficiencia de factor VII.
- 3) Deficiencia de factor XII.
- 4) Inhibidor adquirido frente al factor VII.

Respuesta correcta: 2

P094 MIR 2016-2017

¿Indica cuál de las siguientes afirmaciones en referencia al factor V de Leiden es cierta?

- 1) Se trata de la resistencia del factor V a la acción de la proteína S.
- 2) Es un trastorno adquirido que se asocia a la presencia de anticuerpos anticardiolipina.
- 3) Su presencia ocasiona una prolongación del tiempo de tromboplastina parcial.
- 4) Junto con la mutación de la protrombina constituye la predisposición trombótica de base genética más frecuente en nuestro medio.

Respuesta correcta: 4

P107 MIR 2017-2018

Una mujer de 32 años consulta porque desea quedarse embarazada y refiere antecedentes de episodio de embolia de pulmón siete años antes mientras estaba tomando anticonceptivos orales. Se le realizó tratamiento con acenocumarol durante seis meses. El estudio de trombofilia fue negativo. Se aconseja realizar profilaxis de trombosis venosa en el caso de que quede embarazada. Señale la afirmación CORRECTA:

- 1) Debe aconsejarse tratamiento profiláctico con heparina de bajo peso molecular durante el embarazo y hasta 6 semanas posparto.
- 2) Debe aconsejarse tratamiento profiláctico con aspirina durante todo el embarazo.
- 3) Debe aconsejarse realizar profilaxis con acenocumarol durante todo el embarazo.
- 4) Dado que el estudio de trombofilia fue negativo, solo se precisa realizar profilaxis de trombosis venosa con medias compresivas para miembros inferiores.

Respuesta correcta: 1

P097 MIR 2018-2019

Hombre de 35 años ingresado por un primer episodio de tromboembolismo pulmonar. Se ha iniciado tratamiento anticoagulante con heparina sódica pero el paciente no alcanza rangos de TTPa terapéuticos. ¿Qué entidad sospecharía?

- 1) Déficit de proteína C.
- 2) Anticoagulante lúpico.
- 3) Mutación factor V Leiden.
- 4) Déficit de antitrombina.

Respuesta correcta: 4

P102 MIR 2018-2019

¿Cuál es el diagnóstico MÁS probable de un paciente con trombopenia progresiva, niveles de fibrinógeno bajos, alargamiento de los tiempos de protrombina y tromboplastina parcial activada, aumento de los dímeros-D y esquistocitos en el frotis de sangre periférica?

- 1) Coagulación intravascular diseminada.
- 2) Púrpura trombótica trombocitopénica.

- 3) Síndrome antifosfolípido catastrófico.
- 4) Enfermedad de Von Willebrand.

Respuesta correcta: 1

P148 MIR 2022-2023

Varón de 35 años, diagnosticado de hemofilia A desde la infancia, que recibe un trasplante hepático por hepatopatía crónica por virus de hepatitis C. Seis meses después del procedimiento presenta un estudio de coagulación normal con actividad de factor VIII del 100%. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CIERTA?

- 1) La hemofilia se ha curado ya que el factor VIII se sintetiza en el hígado.
- 2) El tratamiento inmunosupresor ha solucionado el problema ya que estamos ante un cuadro autoinmune.
- 3) La larga vida media de los factores anti-hemofílicos usados en el trasplante hace que su efecto perdure varios meses.
- 4) Solo puede tratarse de un error o artefacto de laboratorio, ya que la hemofilia A es una enfermedad genética incurable hoy en día.

Respuesta correcta: 1

P150 MIR 2022-2023

Varón de 41 años ingresado en la UCI por neumonía grave que precisa intubación y administración de catecolaminas. A la exploración se observa sangrado alrededor de los lugares de venopunción. Sus resultados de laboratorio son: 15.500 leucocitos; Hb 10,4 g/dL; hematocrito 32%; 52.000 plaquetas; LDH 820 U (normal 110-210); recuento de reticulocitos 4%. ¿Cuál de los siguientes resultados NO es de esperar en este paciente?

- 1) Fibrinógeno bajo.
- 2) Concentración elevada de antitrombina y proteína C.
- 3) Tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina activada alargados.
- 4) Presencia de productos de degradación de la fibrina (dímero D).

Respuesta correcta: 2

P145 MIR 2024-2025

Hombre de 17 años con hemofilia A grave e inhibidor de alto título frente al FVIII que

presenta sangrado agudo a nivel articular. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es el más indicado para controlar la hemorragia?

- 1) Desmopresina.
- 2) Emicizumab.
- 3) Ácido tranexámico.
- 4) Factor VII activado recombinante.

Respuesta correcta: 4

P176 MIR 2025-2026

Un varón de 11 meses presenta irritabilidad y llanto al movilizar la extremidad inferior derecha. En la exploración física destaca una tumefacción de la rodilla derecha, que se muestra caliente y enrojecida. En el estudio básico de coagulación se observa: tiempo de protrombina (TP) de 11 segundos (rango: 9-15 segundos) y un tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA) de 80 segundos (rango: 20-40 segundos). Se solicita una prueba de mezclas que corrige la alteración de la coagulación. ¿Qué opción diagnóstica NO se ajusta a las alteraciones analíticas observadas?

- 1) Déficit de factor VII.
- 2) Déficit de factor VIII.
- 3) Déficit de factor IX.
- 4) Enfermedad de von Willebrand tipo 3.

Respuesta correcta: 1

T17 Terapias en hematología

P107 MIR 2009-2010

Un paciente de 75 años de edad, afecto de leucemia linfática crónica, en tratamiento con fludarabina vía oral, ingresa por cuadro de rectorragia presentando anemia de 7,5 g/dL con reticulocitosis, Coombs directo negativo, bilirrubina indirecta, LDH y haptoglobina normales. Se transfunde 2 concentrados de hematíes. A las 72 horas del ingreso presenta cuadro febril con exantema maculopapular en palmas y plantas y elevación de fosfatasa alcalina y GGT. El cuadro es compatible con:

- 1) Reacción injerto contra huésped transfusional.
- 2) Infección por virus hepatitis C.

- 3) Infección por virus hepatitis B.
- 4) Síndrome de Richter.
- 5) Transformación a leucemia prolinfocítica.

Respuesta correcta: 1

P112 MIR 2009-2010

¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a los fármacos anticoagulantes es cierta?

- 1) Los cumarínicos tienen pocas interacciones farmacológicas.
- 2) El tratamiento de la trombocitopenia inducida por heparina consiste en la disminución de la dosis de heparina.
- 3) Los cumarínicos son seguros durante todo el embarazo.
- 4) El test más utilizado para el control de la heparina no fraccionada es el TTPA (tiempo de tromboplastina parcial activada).
- 5) El fondaparinux es un nuevo anticoagulante de administración oral.

Respuesta correcta: 4

P100 MIR 2011-2012

De todas las siguientes, ¿Cuál es la complicación que puede observarse en los enfermos que reciben heparina?

- 1) Insuficiencia renal aguda.
- 2) Anemia hemolítica autoinmune.
- 3) Trombosis venas suprahepáticas.
- 4) Síndrome leucoeritroblástico.
- 5) Plaquetopenia.

Respuesta correcta: 5

P199 MIR 2011-2012

¿De cuál de los siguientes fármacos no se suele realizar la determinación de las concentraciones plasmáticas en la práctica clínica?

- 1) Acenocumarol.
- 2) Gentamicina.
- 3) Digoxina.
- 4) Fenitoína.
- 5) Litio.

Respuesta correcta: 1

P046 MIR 2013-2014

¿Cuál de los siguientes emparejamientos entre fármaco anticoagulante y mecanismo de acción es INCORRECTO?

- 1) Heparina - cofactor de la antitrombina III.
- 2) Acenocumarol - inhibe la vitamina K epóxido reductasa.
- 3) Dabigatrán - inhibe la trombina.
- 4) Rivaroxabán - inhibe el factor Xa.
- 5) Warfarina - inhibe la absorción de la vitamina K.

Respuesta correcta: 5

P210 MIR 2014-2015

De los siguientes anticoagulantes, ¿cuál es un inhibidor directo de la trombina?

- 1) Dabigatrán.
- 2) Apixabán.
- 3) Rivaroxabán.
- 4) Acenocumarol.
- 5) Clopidogrel.

Respuesta correcta: 1

P093 MIR 2015-2016

Mujer de 46 años, con antecedentes de valvulopatía reumática, que precisa sustitución valvular mitral por una prótesis mecánica. La evolución postoperatoria inicial es favorable. Sin embargo, tras comenzar tratamiento con acenocumarol, desarrolla un cuadro de necrosis cutánea, afectando a región abdominal y extremidades. ¿Cuál de las siguientes alteraciones justificaría este cuadro?

- 1) Deficiencia de antitrombina.
- 2) Factor V Leiden.
- 3) Hiperhomocisteinemia.
- 4) Deficiencia de proteína C.

Respuesta correcta: 4

P097 MIR 2015-2016

Paciente de 35 años que, debido a hematemesis por *ulcus*, recibe una transfusión de 2 concentrados de hematíes. A los 5-10 minutos de iniciarse la transfusión,



comienza con fiebre, escalofríos, hipotensión y dolor en región lumbar. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable?

- 1) Contaminación bacteriana de la sangre.
- 2) Reacción febril secundaria a la transfusión.
- 3) Reacción febril por el plasma que contamina los hematíes.
- 4) Reacción transfusional hemolítica.

Respuesta correcta: 4

P098 MIR 2015-2016

El médico de guardia solicita al banco de sangre hemoderivados para un paciente politraumatizado del grupo A+. Si no se dispusiera de éste, ¿Cuál de los siguientes sería el tratamiento alternativo más correcto?

- 1) Concentrado de hematíes del grupo AB+ y plasma AB.
- 2) Concentrado de hematíes del grupo B+ y plasma AB.
- 3) Concentrado de hematíes del grupo O+ y plasma AB.
- 4) Concentrado de hematíes del grupo B+ y plasma B.

Respuesta correcta: 3

Respuesta correcta:

P099 MIR 2015-2016

Respecto a la enfermedad del injerto contra huésped (EICH) post-trasplante de progenitores hematopoyéticos, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- 1) El proceso fisiopatológico de la EICH tiene su origen en las células T del donante.
- 2) La profilaxis de la EICH consiste en tratamiento inmunosupresor, frecuentemente ciclosporina asociada a metotrexate, y el tratamiento de la EICH establecida consiste en corticoterapia.
- 3) La eliminación de los linfocitos del donante del injerto mejora el implante de los progenitores.
- 4) En la mayoría de los pacientes diagnosticados de EICH crónica, esta llega a desaparecer, pudiendo interrumpir el tratamiento inmunosupresor.

Respuesta correcta: 3

P038 MIR 2016-2017

Además de la hemorragia, un efecto adverso grave de la heparina es:

- 1) Hipopotasemia.
- 2) Alcalosis metabólica.
- 3) Diarrea.
- 4) Trombocitopenia.

Respuesta correcta: 4

P095 MIR 2016-2017

Paciente de 73 años de edad, anticoagulado con acenocumarol por fibrilación auricular. Acude a Urgencias por cefalea de rápida instauración de una hora de evolución, observándose en neuroimagen, hemorragia hemisférica cerebral intraparenquimatosa de 1 cm de diámetro. En la analítica se observa un INR de 4. ¿Cuál es el tratamiento más correcto de los indicados?

- 1) Suspensión de acenocumarol.
- 2) Administración de vitamina K (vía oral) y suspensión de acenocumarol.
- 3) Administración de vitamina K vía endovenosa con plasma fresco congelado y suspensión de acenocumarol.
- 4) Administración de vitamina K vía endovenosa, concentrado de complejo protrombínico o factor VII activado recombinante (rFVIIa) y suspensión de acenocumarol.

Respuesta correcta: Anulada

P108 MIR 2017-2018

Respecto al tratamiento anticoagulante indique la respuesta FALSA:

- 1) Dabigatrán - Inhibidor directo de la trombina.
- 2) Prasugrel - Inhibidor de agregación y activación plaquetaria.
- 3) Edoxabán - Inhibidor directo de factor Xa.
- 4) Idarucizumab - Inhibidor de la activación del plasminógeno.

Respuesta correcta: Anulada

P109 MIR 2017-2018

Hombre de 35 años con leucemia mieloide aguda sometido a alotrasplante de progenitores hematopoyéticos con acondi-

cionamiento mieloablativo. Se encuentra en tratamiento con *tacrolimus* en rango terapéutico y profilaxis con aciclovir y un azol. Estando ambulatorio y sin complicaciones previas, acude al hospital en el día +24 postrasplante con eritema cutáneo generalizado que afecta con mayor intensidad a palmas y plantas, cara, cuello, tronco, flancos y cara interna de los muslos. Es de reciente aparición (24-48 horas) y se acompaña de anorexia, náuseas, diarrea acuosa y dolor abdominal. ¿Cuál es la actitud terapéutica MÁS adecuada?

- 1) Suspender lo antes posible el tratamiento inmunosupresor con *tacrolimus*.
- 2) Iniciar tratamiento con esteroides a dosis altas.
- 3) Iniciar infusión de linfocitos del donante.
- 4) Iniciar tratamiento con fotoaféresis extracorpórea.

Respuesta correcta: 2

P113 MIR 2017-2018

Con respecto al trasplante de progenitores hematopoyéticos señale la afirmación FALSA:

- 1) En pacientes que carecen de un donante familiar o no emparentado HLA-idéntico se puede emplear la sangre de cordón umbilical como fuente alternativa.
- 2) En pacientes que carecen de un donante familiar o no emparentado HLA-idéntico se pueden emplear células progenitoras de un donante haploidéntico.
- 3) En el trasplante autólogo las células se encuentran criopreservadas y han de descongelarse previo a su administración.
- 4) El efecto injerto contra leucemia es mayor en el trasplante autólogo que en el alogénico.

Respuesta correcta: 4

P040 MIR 2018-2019

¿Por qué razón el ácido acetilsalicílico a dosis bajas (< 325 mg) tiene MAYOR efecto antiagregante plaquetario que la mayoría de los otros AINES?

- 1) Porque es inhibidor selectivo de la COX-1.
- 2) Porque es un inhibidor irreversible.

- 3) Porque da lugar a un metabolito, el ácido salicílico, que tiene una semivida en plasma muy prolongada.
- 4) Porque inhibe la tromboxano sintetasa.

Respuesta correcta: 2

P098 MIR 2018-2019

Hombre de 75 años que recibe tratamiento anticoagulante con dabigatrán por una fibrilación auricular. Acude al Servicio de Urgencias por hemorragia digestiva en forma de melenas. Se realiza analítica en la que presenta Hb 6,8 g/dL, plaquetas 234.000/mm³, creatinina 1,5 mg/dL, TTPa 60 segundos. Ha tomado la última dosis de dabigatrán hace 4 horas y precisa realización de endoscopia urgente. ¿Qué fármaco utilizaría para revertir el efecto del dabigatrán?

- 1) Vitamina K.
- 2) Idarucizumab.
- 3) Plasma fresco congelado.
- 4) Sulfato de protamina.

Respuesta correcta: 2

P103 MIR 2018-2019

De las diferentes reacciones adversas que se pueden presentar tras una transfusión, ¿Cuál puede ser prevenida con la modificación del componente sanguíneo?

- 1) Las reacciones hemolíticas tardías, ya que las pruebas de detección de anticuerpos previas a la transfusión son positivas y por tanto se transfundirá sangre carente del antígeno.
- 2) La hipocalcemia puede ser prevenida mediante la retirada del citrato que llevan los concentrados de hematíes.
- 3) El lavado de los concentrados de hematíes previene la sobrecarga férrica en los pacientes politransfundidos.
- 4) La irradiación de los componentes celulares (concentrados de hematíes y plaquetas) con 2.500 cGy evita la aparición de la enfermedad injerto contra huésped asociada a la transfusión.

Respuesta correcta: 4

P104 MIR 2018-2019

Mujer de 47 años diagnosticada de enfermedad de Waldenström agresiva tras

4 líneas de tratamiento y recidiva precoz post trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. Tras tratamiento de rescate se obtiene buena respuesta. Como tiene un hermano HLA idéntico, se realiza intensificación con trasplante alogénico de progenitores con acondicionamiento con fludarabina y Busulfán. En el día 14 tras infusión de progenitores se aprecia aumento progresivo de peso, con aumento de bilirrubina hasta 4,5 mg/dL y molestias abdominales difusas sin fiebre, con hepatomegalia moderada ligeramente dolorosa y oleada ascítica positiva. ¿Cuál es la actitud MÁS adecuada en este caso?

- 1) Iniciar tratamiento con esteroides a dosis altas ante posibilidad de enfermedad aguda injerto contra huésped hepática.
- 2) Ampliar cobertura antibiótica ante posibilidad de complicación infecciosa.
- 3) Considerar síndrome de obstrucción sinusoidal y valorar iniciar tratamiento con defibrotide.
- 4) Tratamiento sintomático y ver evolución.

Respuesta correcta: 3

P013 MIR 2019-2020

Pregunta vinculada a la imagen nº 13. Mujer de 72 años con antecedentes de fibrilación auricular en tratamiento con anticoagulantes orales. Presenta dolor abdominal focalizado en hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. INR 5. Hemoglobina 8,7 g/dL, hematocrito 25%. ¿Cuál es el diagnóstico que le sugiere la imagen vinculada?

- 1) Hernia complicada de pared abdominal.
- 2) Seroma postquirúrgico.
- 3) Absceso en la vaina del recto anterior izquierdo del abdomen.
- 4) Hematoma en la vaina del recto anterior izquierdo del abdomen.

Respuesta correcta: 4

P057 MIR 2020-2021

¿Cuál de las siguientes situaciones NO es una indicación de los anticoagulantes orales de acción directa?

- 1) Portador de prótesis valvular aortica mecánica.

- 2) Tratamiento del tromboembolismo pulmonar.
- 3) Profilaxis de la trombosis venosa en el postoperatorio de prótesis de rodilla.
- 4) Prevención de ictus en fibrilación auricular no valvular.

Respuesta correcta: 1

P159 MIR 2021-2022

Además de las posibles complicaciones hemorrágicas ¿qué otro efecto adverso del tratamiento parenteral con heparina puede ser grave y comprometer la vida del paciente?

- 1) Hipopotasemia extrema.
- 2) Trastornos gastrointestinales con diarrea abundante y deshidratación.
- 3) Alcalosis metabólica por toxicidad tubular renal.
- 4) Trombopenia grave acompañada de fenómenos trombóticos venosos o arteriales.

Respuesta correcta: 4

P156 MIR 2023-2024

Un paciente con grupo sanguíneo A positivo y una leucemia mieloide aguda es sometido a un trasplante hematopoyético con un donante B positivo. La médula del donante prende adecuadamente alcanzando un quimerismo completo. Sin haber recibido transfusiones en los cuatro meses previos, a los seis meses del procedimiento, permaneciendo en quimerismo completo, se realiza un nuevo grupo sanguíneo al receptor. El resultado será:

- 1) A positivo. El grupo sanguíneo permanece inalterable durante toda la vida.
- 2) AB positivo. Existe una mezcla de ambos grupos en los hematíes.
- 3) B positivo. Ha cambiado de grupo adquiriendo el del donante.
- 4) O positivo. Los anticuerpos anti-transferasa del receptor inhiben la expresión de los grupos sanguíneos, siendo todos los pacientes trasplantados del grupo O.

Respuesta correcta: 3

P177 MIR 2023-2024

Mujer de 75 años con antecedentes de insuficiencia venosa crónica que acude



a urgencias por edema unilateral infra-poplíteo de extremidad inferior derecha, diagnosticándose de trombosis venosa profunda de venas gemelares derechas. Dado que no presenta ninguna otra comorbilidad ni clínica de embolia pulmonar se plantea el alta hospitalaria con

tratamiento y seguimiento en consultas externas. ¿Cuál de estos fármacos es el MENOS indicado para iniciar tratamiento anticoagulante?

- 1) Rivaroxaban.
- 2) Enoxaparina.

- 3) Acenocumarol.
- 4) Fondaparinux.

Respuesta correcta: 3